# پاسخ‌نامهٔ میان‌ترم و بلوپرینت‌های پرستاری بیماری‌های کودکان ۲

بر اساس کتاب وانگ (Wong) — پرستاری کودکان (کودک بیمار)، ویرایش ۲۰۲۴

**نکات قبل از مطالعه:**

- در فایل‌های بلوپرینت فقط صورت سوال‌ها آمده و گزینه‌ها نیست؛ پاسخ هر سوال همراه توضیح بخش مربوطه نوشته شده است.
- سوال‌های تکراری با برچسب «سوال تکراری» مشخص شده‌اند و ارجاع داده‌ام که توضیح کامل در کدام سوال/فایل آمده است.
- شمارهٔ فصل‌ها بر اساس بلوپرینت‌هاست؛ شمارهٔ صفحه‌ها را وارد نکردم تا اشتباه نباشد.
- سوال‌هایی که علامت ⚠ دارند (مثلاً ۶ میان‌ترم، ۲۵ بلوپرینت ۴۰۴۱ و ۱۴ بلوپرینت ۴۰۴۲) بیشتر وابسته به جزوهٔ استاد هستند؛ اگر جزوه پاسخ دیگری داده همان ملاک است.

## بخش اول: سوالات میان‌ترم (۱۷ سوال)

۱

**در شیرخوار مبتلا به هایپوتیروئیدیسم کدام یک از علائم زیر ناشی از عدم دریافت کافی دارو می‌باشد؟**

الف) تحریک‌پذیری و تنگی نفس

ب) کاهش وزن و تعریق زیاد

ج) یبوست و خواب‌آلودگی

د) افزایش نبض و درجه حرارت

**پاسخ:** گزینه «ج» — یبوست و خواب‌آلودگی

**توضیح:** در هایپوتیروئیدی مادرزادی درمان با لووتیروکسین (تیروکسین) مادام‌العمر است. اگر دوز دارو کم باشد، علائم «کم‌کاری» برمی‌گردد: یبوست، خواب‌آلودگی و بی‌حالی، تغذیه ضعیف، زبان بزرگ، پوست خشک و سرد، نبض آهسته، فونتانل بزرگ، زردی طولانی و فتق نافی. گزینه‌های الف، ب و د همگی علائم «پرکاری/مسمومیت دارویی» (دوز زیاد) هستند: تحریک‌پذیری، تعریق، کاهش وزن، تاکی‌کاردی و تب. نکته: غربالگری نوزادی (TSH) بین ۲ تا ۴ روزگی انجام می‌شود و شروع درمان تا ۲ هفتگی از عقب‌ماندگی ذهنی جلوگیری می‌کند.

۲

**بروز کدام یک از علائم زیر در سپسیس با پیش‌آگهی بد همراه است؟**

الف) لکوسیتوز

ب) لکوپنی

ج) اختلالات الکترولیتی

د) هیپوکسی

**پاسخ:** گزینه «ب» — لکوپنی (نوتروپنی)

**توضیح:** در سپسیس نوزادی، لکوسیتوز پاسخ نسبتاً شایع و غیراختصاصی به عفونت است، ولی لکوپنی/نوتروپنی (WBC کمتر از ۵۰۰۰ یا ANC پایین و نسبت نابالغ به کل نوتروفیل‌ها I/T بیش از ۰٫۲) نشانهٔ تخلیهٔ ذخایر مغز استخوان و پیش‌آگهی بد است. سایر علائم بد: ترومبوسیتوپنی، DIC، هیپوتانسیون و شوک. علائم اولیه سپسیس نوزاد غیراختصاصی‌اند: بی‌حالی، تغذیه ضعیف، بی‌ثباتی دما، آپنه، رنگ‌پریدگی/خاکستری شدن، نفخ شکم.

۳

**بهترین شیوه اکسیژن‌رسانی در نوزاد مبتلا به فتق دیافراگمی کدام است؟**

الف) ماسک ساده صورت

ب) سوند نازال

ج) هود

د) اینتوبه کردن

**پاسخ:** گزینه «د» — اینتوبه کردن (لوله‌گذاری تراشه)

**توضیح:** در فتق دیافراگمی مادرزادی (CDH) احشای شکمی وارد قفسهٔ سینه شده و باعث هیپوپلازی ریه می‌شود. ماسک و آمبوبگ باعث ورود هوا به معده و روده می‌شود، احشا بیشتر منبسط شده و ریه را فشار می‌دهد؛ بنابراین تهویه با ماسک ممنوع است. اقدام درست: اینتوباسیون فوری + سوند معده (NG/OG) با ساکشن پیوسته برای تخلیهٔ معده + وضعیت سر بالا و خوابیدن روی «سمت مبتلا» تا ریه سالم آزادتر باشد.

۴

**نوزادی که در اولین تغذیه دهانی دچار استفراغ، آسپیراسیون، سرفه و سیانوز می‌شود چه تشخیصی برای وی مطرح است؟**

الف) آترزی مری

ب) انسداد روده

ج) شکاف کام

د) فتق دیافراگمی

**پاسخ:** گزینه «الف» — آترزی مری (معمولاً همراه فیستول تراکئوازوفاژیال TEF)

**توضیح:** سه علامت کلاسیک آترزی مری: سرفه، خفگی (choking) و سیانوز با تغذیه؛ همچنین ترشح کف‌آلود و زیاد دهان (drooling) از بدو تولد. عبور ندادن سوند معده (NG) از مری هم تشخیصی است. اقدام: NPO، وضعیت سر بالا، ساکشن مداوم قسمت فوقانی مری (سوند Replogle)، آنتی‌بیوتیک و جراحی. شایع‌ترین نوع (حدود ۸۵٪): آترزی با فیستول در قطعهٔ تحتانی (Type C). بررسی همراه با VACTERL ضروری است.

۵

**اولین اقدام پرستار بعد از تشخیص آنوس بسته (ناهنجاری آنورکتال) چیست؟**

الف) گاواژ

ب) قطع تغذیه دهانی

ج) دادن اکسیژن

د) تغذیه وریدی

**پاسخ:** گزینه «ب» — قطع تغذیه دهانی (NPO)

**توضیح:** در آنوس بسته (Imperforate anus) انسداد دفع مدفوع وجود دارد؛ تغذیه دهانی باعث استفراغ و انسداد/پارگی روده می‌شود. اولین اقدام NPO کردن نوزاد است، سپس مایع وریدی (و در صورت نیاز تغذیهٔ وریدی)، تخلیهٔ معده با سوند و آماده‌سازی برای جراحی (کلستومی موقت و بعداً PSARP). بررسی از نظر فیستول (رکتوواژینال، رکتویورترال، رکتوپرینه‌آل) و ناهنجاری‌های همراه (VACTERL) انجام می‌شود.

۶

**در کدام یک از ناهنجاری‌های زیر ادم اندام تحتانی دیده می‌شود؟**

الف) آمفالوسل

ب) آترزی مری

ج) فتق دیافراگماتیک

د) ناهنجاری‌های آنورکتال

**پاسخ:** گزینه «الف» — آمفالوسل (با احتیاط؛ به یادداشت استاد نگاه کنید)

**توضیح:** در آمفالوسل بزرگ، احشای خارج‌شده (کبد، روده) می‌تواند با فشار روی ورید اجوف تحتانی و کاهش بازگشت وریدی باعث ادم اندام تحتانی شود؛ در سه گزینهٔ دیگر چنین یافته‌ای مطرح نیست. ⚠ این سؤال در کتاب وانگ به‌صورت مستقیم نیامده و بیشتر سلیقهٔ جزوه استاد است؛ اگر در جزوهٔ کلاس پاسخ دیگری آمده همان را ملاک بگیرید. نکتهٔ مهم آمفالوسل: پوشش کیسه با گاز استریل مرطوب سالین، حفظ دما، NG با ساکشن، مایع وریدی و آنتی‌بیوتیک؛ برخلاف گاستروشیزی، کیسه دارد (غشای پریتوان) و ناهنجاری‌های همراه (بکویث–ویدمان، ناهنجاری قلبی) شایع است.

۷

**اگر انکوباتور نوزاد در محیط سرد قرار گیرد، از چه طریقی حرارت بدن نوزاد از دست خواهد رفت؟**

الف) انتقال (هدایت)

ب) تابشی

ج) وزش (همرفت)

د) تبخیر

**پاسخ:** گزینه «ب» — تابشی (Radiation)

**توضیح:** چهار راه اتلاف حرارت: ۱) تابش (Radiation): از بدن به سطوح سردِ نزدیک ولی بدون تماس (دیوارهٔ انکوباتور سرد، پنجره)؛ ۲) هدایت (Conduction): تماس مستقیم با سطح سرد (تخت، ترازو)؛ ۳) همرفت (Convection): جریان هوا (کولر، باز بودن در)؛ ۴) تبخیر (Evaporation): خشک نکردن پوست مرطوب و حمام. دیوارهٔ شفاف انکوباتور در اتاق سرد سرد می‌شود و نوزاد بدون تماس با آن حرارت را از دست می‌دهد؛ برای پیشگیری از انکوباتور دو جداره، دور از پنجره و کولر و گرم کردن اتاق استفاده می‌شود.

۸

**در شیرخوار مبتلا به مننگومیلوسل برای رفع احتباس ادراری به دلیل مثانه نورروژنیک اقدام مناسب کدام است؟**

الف) ماساژ ناحیه شکم شیرخوار

ب) استفاده از سوند نلاتون به طور متناوب

ج) استفاده از سوند فولی

د) استفاده از روش کرده (Credé)

**پاسخ:** گزینه «ب» — سونداژ متناوب تمیز (CIC) با سوند نلاتون

**توضیح:** مثانهٔ نورروژنیک در مننگومیلوسل باعث احتباس ادرار، ریفلاکس و عفونت و آسیب کلیه می‌شود. بهترین روش، سونداژ متناوب تمیز (Clean Intermittent Catheterization) با سوند نلاتون است که حجم باقی‌مانده را کم و خطر عفونت را کاهش می‌دهد و بعداً به والدین/خود کودک آموزش داده می‌شود. سوند فولی دائم خطر UTI را بالا می‌برد. روش Credé (فشار دستی روی مثانه) ممکن است ریفلاکس را بدتر کند و روش اول انتخاب نیست. نکتهٔ دیگر: به دلیل شیوع آلرژی به لاتکس در این کودکان، از وسایل بدون لاتکس استفاده شود.

۹

**کدام یک از موارد زیر جزء عوارض ازدیاد بار مایع در نوزاد نیست؟**

الف) خونریزی داخل بطنی

ب) نارسایی احتقانی قلب

ج) آسیب دیواره عروق

د) باز ماندن کانال شریانی

**پاسخ:** گزینه «ج» — آسیب دیواره عروق

**توضیح:** در نوزاد نارس، مایع اضافی با عوارضی مثل باز ماندن مجرای شریانی (PDA)، نارسایی احتقانی قلب (CHF)، خونریزی داخل بطنی (IVH)، دیسپلازی برونکوپولمونر (BPD)، انتروکولیت نکروزان (NEC) و ادم ریه همراه است. «آسیب دیواره عروق» از عوارض ازدیاد بار مایع نیست. بنابراین در مراقبت از نوزاد نارس، دقت در ورودی/خروجی، وزن روزانه و جلوگیری از مایع اضافی مهم است.

۱۰

**کدام یک از علائم زیر نشان‌دهنده انسداد شانت بطنی–صفاقی در شیرخوار مبتلا به هیدروسفالی می‌باشد؟**

الف) افزایش درجه حرارت و خواب‌آلودگی

ب) تحریک‌پذیری و برجستگی فونتانل‌ها

ج) احتباس ادراری و پوست سرد

د) اسهال و استفراغ شدید

**پاسخ:** گزینه «ب» — تحریک‌پذیری و برجستگی فونتانل‌ها

**توضیح:** انسداد شانت یعنی افزایش فشار داخل جمجمه (ICP). در شیرخوار: برآمدگی و تنش فونتانل قدامی، تحریک‌پذیری، استفراغ، خواب‌آلودگی، گریهٔ تیز، بدتر شدن تغذیه، افزایش دور سر، چشم‌های «غروب خورشید» (sunsetting) و جدا شدن درزها؛ در کودک بزرگ‌تر: سردرد، استفراغ، تاری دید. اگر عفونت شانت باشد، تب و قرمزی مسیر شانت هم دیده می‌شود. اقدام: گزارش فوری و آمادگی برای بازبینی شانت؛ به‌طور کلی پرستار شانت را پمپ نمی‌کند مگر دستور باشد.

۱۱

**کدام یک از تست‌های تشخیصی زیر در CDH (دیسپلازی تکاملی مفصل ران) دیرتر از بقیه تست‌ها قابل اندازه‌گیری می‌باشد؟**

الف) ارتولانی

ب) بارلو

ج) ترندلنبرگ

د) الیس

**پاسخ:** گزینه «ج» — ترندلنبرگ

**توضیح:** ارتولانی (جا انداختن مفصل دررفته با کلیک) و بارلو (دررفتگی با فشار) در دورهٔ نوزادی ارزیابی می‌شوند و تا ۲–۳ ماهگی مثبت‌اند. علامت الیس/گالیازی (کوتاهی ظاهری ران، ارتفاع نابرابر زانوها) از حدود ۳ ماهگی تا بزرگ‌تر قابل بررسی است. علامت ترندلنبرگ (افتادن لگن سمت مقابل هنگام ایستادن روی پای مبتلا) فقط وقتی کودک راه می‌افتد (حدود ۱۲ ماهگی به بعد) قابل ارزیابی است. اقدامات: نوزادان با چنبره (Pavlik harness)، بعد از ۶ ماهگی گچ اسپایکا/جراحی؛ سونوگرافی تا ۴–۶ ماهگی و رادیوگرافی بعد از آن.

۱۲

**در مورد پای چماقی (Clubfoot) یک‌طرفه کدام مورد صحیح نمی‌باشد؟**

الف) پای مبتلا کوچک‌تر و کوتاه‌تر است

ب) پاشنه پا بدون برجستگی می‌باشد

ج) چین عرضی در کف پا دیده می‌شود

د) کودک مبتلا اکثراً مونث می‌باشد

**پاسخ:** گزینه «د» — کودک مبتلا اکثراً مونث است (نادرست)

**توضیح:** پای چماقی در پسرها حدود ۲ برابر دخترها شایع است؛ پس «اکثراً مونث» نادرست است. ویژگی‌ها: پای مبتلا کوچک‌تر/کوتاه‌تر، ساق لاغرتر، پاشنه بدون برجستگی (empty heel)، چین عمیق عرضی در کف/سمت داخل پا، و ۴ جزء تغییر شکل (CAVE): Cavus، Adductus، Varus، Equinus. درمان: روش Ponseti (گچ‌گیری متوالی هفتگی از چند روز اول تولد + تنوتومی آشیل + بریس). نکتهٔ پرستاری: بررسی نوروواسکولار انگشتان بعد از گچ و آموزش مراقبت از گچ به والدین.

۱۳

**مهم‌ترین عارضه فتق دیافراگمی ..... و ..... می‌باشد.**

**پاسخ:** هیپوپلازی ریه (کوچک ماندن ریه) و هیپرتانسیون ریوی پایدار نوزاد (PPHN)

**توضیح:** احشای شکمی در دوران جنینی وارد قفسهٔ سینه شده و رشد ریه (معمولاً ریهٔ همان طرف و گاهی طرف مقابل) را مختل می‌کنند؛ نتیجه کاهش تعداد آلوئول و عروق ریوی، فشار شریان ریوی بالا و شانت راست به چپ و هیپوکسی شدید است. مرگ‌ومیر بالای CDH به همین دو عارضه است.

۱۴

**بهترین پوزیشن بعد از جراحی شکاف کام ..... می‌باشد.**

**پاسخ:** خوابیدن به پهلو یا روی شکم (Prone/Side-lying) تا ترشحات از دهان تخلیه شوند

**توضیح:** بعد از پالاتوپلاستی (ترمیم شکاف کام) کودک را به‌صورت دمر یا به پهلو می‌خوابانند تا خون و ترشحات از دهان خارج شود و خطر آسپیراسیون کم شود (برای شکاف لب، برعکس: به پشت یا در صندلی مخصوص شیرخوار تا فشاری به خط بخیه وارد نشود). مراقبت‌های دیگر: بی‌حرکت کردن بازوها (آرنج‌بندها)، پرهیز از گذاشتن هر چیزی در دهان (قاشق، نی، پستانک، انگشت)، تغذیه با فنجان، رژیم مایعات/نرم و کنترل درد.

۱۵

**هدف از تشخیص سریع و درمان زودهنگام فنیل‌کتونوری ..... می‌باشد.**

**پاسخ:** پیشگیری از عقب‌ماندگی ذهنی (آسیب مغزی برگشت‌ناپذیر ناشی از تجمع فنیل‌آلانین)

**توضیح:** در PKU کمبود آنزیم فنیل‌آلانین هیدروکسیلاز باعث تجمع فنیل‌آلانین و آسیب مغز می‌شود. غربالگری از پاشنهٔ پا بعد از ۲۴–۴۸ ساعت از شروع تغذیه با شیر. درمان: رژیم محدود در فنیل‌آلانین از همان اوایل (شیر مخصوص بدون فنیل‌آلانین)، پرهیز از آسپارتام، گوشت، تخم‌مرغ، لبنیات. تشخیص و درمان تا ۳–۴ هفتگی از عقب‌ماندگی ذهنی جلوگیری می‌کند.

۱۶

**یکی از مهم‌ترین عوامل خطر در انتروکولیت نکروزان ..... می‌باشد.**

**پاسخ:** نارسی (پره‌مچوریتی) — به‌خصوص همراه با تغذیهٔ روده‌ای

**توضیح:** NEC بیشتر در نوزادان نارس رخ می‌دهد؛ عوامل دیگر: ایسکمی/هیپوکسی روده (آسفیکسی، PDA)، شروع و افزایش سریع تغذیه (مخصوصاً شیر مصنوعی)، کلونیزاسیون باکتریایی. علائم: نفخ شکم، باقی‌ماندهٔ معده، استفراغ صفراوی، مدفوع خونی، بی‌حالی. اقدام: NPO، NG با ساکشن، آنتی‌بیوتیک وریدی، اندازه‌گیری دور شکم و TPN. تغذیه با شیر مادر عامل محافظ است.

۱۷

**بهترین زمان برای جراحی در هیپوسپادیازیس چه زمانی است و چرا؟**

**پاسخ:** ۶ تا ۱۲ ماهگی (حداکثر تا ۱۸ ماهگی)، قبل از آنکه کودک از ناهنجاری آگاه شود

**توضیح:** دلیل: کاهش عوارض روانی و تصویر ذهنی (قبل از آگاهی کودک از اندام تناسلی و قبل از آموزش توالت)، پایین بودن خطر بیهوشی نسبت به نوزادی و اندازهٔ مناسب بافت برای ترمیم. تا زمان جراحی ختنه نکنید چون از پوستهٔ ختنه‌گاه در ترمیم استفاده می‌شود. در هیپوسپادیاس مئاتوس ادراری در سطح شکمی آلت باز می‌شود و خم‌شدگی (chordee) و پوستهٔ پشتی اضافی دارد. بعد از جراحی سوند/استنت و پانسمان و جلوگیری از ضربه آموزش داده می‌شود.

# بخش دوم: بلوپرینت نیمسال اول (۴۰۴۱) — ۳۴ سوال

۱ مراقبت‌های خانواده‌محور

**مشاهده علائم خشم غیرفعال در والدین به کودک دارای بیماری مزمن نشان‌دهنده کدام مرحله سازش خانواده با مشکل کودک می‌باشد؟**

**پاسخ:** مرحلهٔ «سازگاری/تطابق» (Adjustment)

**توضیح:** واکنش والدین به بیماری مزمن کودک به‌صورت مراحل دیده می‌شود: ۱) **شوک و انکار (Shock/Denial)**: ناباوری، «حتماً اشتباه شده»، دکترگردی؛ ۲) **سازگاری/تطابق (Adjustment)**: خشم (فعال یا غیرفعال)، احساس گناه، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری به کادر درمان یا به همسر؛ خشم غیرفعال یعنی بدون فریاد مثلاً بی‌میلی به همکاری، تأخیر، سردی، لجبازی، یا فراموش‌کردن توصیه‌ها؛ ۳) **پذیرش/بازسازی (Reintegration/Acceptance)**: تمرکز بر توانمندی‌های کودک و بازگشت به زندگی. نقش پرستار: گوش دادن بدون قضاوت، پذیرش خشم، دادن اطلاعات صادقانه و شرکت دادن والدین در تصمیم‌ها و مراقبت (مراقبت خانواده‌محور).

۲ احیای قلبی ریوی

**در حین احیای قلبی ریوی کودک ۴ ساله چه زمانی می‌توان اقدام به لوله‌گذاری تراشه کرد؟**

**پاسخ:** وقتی تهویه با آمبوبگ و ماسک کافی نیست یا احیا طولانی می‌شود؛ توسط فرد ماهر، بدون قطع طولانی ماساژ

**توضیح:** در PALS اولویت اول با ماساژ قفسهٔ سینهٔ باکیفیت و تهویه با ماسک–آمبوبگ است. لوله‌گذاری تراشه اختیاری است و باید توسط فرد مجرب انجام شود، وقتی که تهویه با ماسک مؤثر نباشد، احیا طولانی باشد یا نیاز به راه هوایی مطمئن باشد؛ مدت قطع ماساژ در حین لوله‌گذاری حداکثر ۱۰ ثانیه. پس از لوله‌گذاری: ماساژ مداوم ۱۰۰–۱۲۰/دقیقه با تهویه ۱ نفس هر ۲–۳ ثانیه (۲۰–۳۰ تنفس در دقیقه) بدون توقف. سایز لولهٔ کافدار برای کودک: (سن/۴)+۳٫۵ = حدود ۴٫۵ میلی‌متر. تأیید محل لوله: کاپنوگرافی (مهم‌ترین)، سمع دوطرفه، حرکت قفسه، بخار در لوله، $SpO_2$. نسبت ماساژ به تهویه: ۳۰:۲ (یک نفر امدادگر)، ۱۵:۲ (دو نفر)؛ عمق ماساژ حدود یک‌سوم قطر قفسه (≈۵ سانتی‌متر).

۳ تنیدگی بستری شدن

**برای به حداقل رساندن ترس از صدمهٔ بدنی در یک کودک سن مدرسه، به‌عنوان پرستار کدام اقدام مناسب‌تر می‌باشد؟**

**پاسخ:** آماده‌سازی و توضیح ساده با استفاده از عروسک/تصویر/وسایل واقعی، دادن حق انتخاب و کنترل به کودک، و حفظ حریم خصوصی

**توضیح:** کودک سن مدرسه (۶–۱۲ سال) از آسیب بدنی، از دست دادن کنترل، ناتوانی و مرگ می‌ترسد و تحمل بیمارستان را با «فهمیدن» و «کنترل» بهتر می‌کند. اقدامات: توضیح مرحله‌به‌مرحلهٔ اقدام با زبان صادقانه، نشان دادن وسایل و اجازهٔ دست زدن، دادن گزینه‌های واقعی (کدام دست)، همکاری در مراقبت، پوشش بدن و رعایت حریم خصوصی، ارتباط با همکلاسی‌ها/مدرسه و فعالیت‌های سرگرم‌کننده، اجازهٔ بیان احساسات. ارتباط با سایر گروه‌های سنی: نوزاد (ترس از جدایی)، نوپا (جدایی/از دست دادن کنترل)، پیش‌دبستانی (ترس از آسیب بدنی/تنبیه)، نوجوان (حریم خصوصی/تصویر بدنی/ جدا شدن از گروه همسالان).

۴ پرستاری در اختلالات ایمونولوژیک کودکان

**علت ایجاد ضایعات پوستی در بیماری هنوخ شونلاین چیست؟**

**پاسخ:** واسکولیت (التهاب) عروق کوچک ناشی از رسوب کمپلکس‌های ایمنی IgA — نه کمبود پلاکت

**توضیح:** هنوخ–شونلاین (HSP یا IgA vasculitis): پس از عفونت (معمولاً تنفسی فوقانی)، IgA رسوب کرده و باعث التهاب و نشت خون از عروق کوچک پوست، مفاصل، روده و کلیه می‌شود. علائم: پورپورای قابل لمس (برجسته) روی اندام تحتانی و باسن، آرتریت/آرترالژی، درد کولیکی شکم، خونریزی گوارشی و درگیری کلیه (هماچوری/پروتئین‌اوری). پلاکت و انعقاد طبیعی است (برخلاف ITP). درمان حمایتی؛ استروئید برای درد شدید شکم/درگیری کلیه؛ پیگیری ادرار حداقل ۶ ماه (پیشگیری از نارسایی کلیه).

۵ مراقبت از کودک در حال احتضار

**درک کودک خردسال نسبت به مرگ کدام است؟**

**پاسخ:** مرگ را موقت، برگشت‌پذیر و شبیه خواب یا جدایی می‌داند؛ تفکر جادویی و احساس گناه

**توضیح:** مفهوم مرگ بر حسب مرحله رشد: **شیرخوار**: مفهومی ندارد، فقط جدایی و بی‌توجهی را احساس می‌کند؛ **نوپا/خردسال (۱–۳ سال)**: مرگ را جدایی می‌فهمد، بیشتر از غیبت والد می‌ترسد؛ **پیش‌دبستانی (۳–۶ سال)**: مرگ را موقت/برگشت‌پذیر، مثل خواب یا سفر؛ فکر جادویی («به‌خاطر فکر بد من مرد»)، احساس گناه؛ **سن مدرسه (۶–۱۲)**: مرگ را نهایی و غیرقابل برگشت می‌فهمد، تا حدود ۹ سالگی آن را شخص‌سازی می‌کند (اسکلت، شبح) و بعداً علت‌های بیولوژیک را می‌فهمد؛ **نوجوان**: مفهوم بزرگسال، ولی ممکن است حس شکست‌ناپذیری و خشم داشته باشد. اقدام: صادقانه و ساده صحبت کردن، استفاده نکردن از تعبیرهایی مثل «خوابید»، حضور والدین، و کنترل علائم/درد.

۶ احیای قلبی ریوی

**کودک دو ساله‌ای که حین خوردن میوه دچار چوکینگ شده و سرفهٔ خروسکی دارد و قادر به صحبت و بلع نیست، احتمال انسداد در کدام قسمت راه هوایی مطرح می‌باشد؟**

**پاسخ:** حنجره (راه هوایی فوقانی در سطح لارنکس)

**توضیح:** جسم خارجی حنجره: شروع ناگهانی خفگی، استریدور/سرفهٔ خروسکی، گرفتگی صدا یا ناتوانی در صحبت، آبریزش از دهان و ناتوانی در بلع. جسم خارجی نای: ویز و سرفه، و جسم خارجی برونش: ویز یک‌طرفه و کاهش صدای تنفسی. **اقدام:** اگر سرفه مؤثر است تشویق به سرفه؛ اگر ناتوان از سرفه/گریه/تنفس: بالای ۱ سال ضربات شکمی (مانور هایملیخ)، زیر ۱ سال ۵ ضربهٔ پشت + ۵ فشار قفسهٔ سینه (به سوال ۱۹ بلوپرینت ۴۰۴۲ مراجعه شود)، در صورت بی‌هوشی شروع CPR و نگاه به دهان برای جسم قابل مشاهده. ضربات شکمی روی کودک خوابیده و «جارو کردن کور انگشت» ممنوع است.

۷ تنیدگی بستری شدن

**به‌عنوان پرستار در مراقبت از کودک خردسال بستری در بیمارستان، به کدام نکته باید توجه کنید؟**

**پاسخ:** اضطراب جدایی؛ حضور والدین (اتاق مشترک)، حفظ روال‌های عادی و وسایل آشنا

**توضیح:** مهم‌ترین تنیدگی بستری شدن برای نوپا (۱–۳ سال) اضطراب جدایی است. سه مرحلهٔ جدایی: **اعتراض** (گریه، چنگ زدن، رد غریبه‌ها)، **ناامیدی** (کناره‌گیری، بی‌علاقگی، گریهٔ آرام، کاهش فعالیت)، **انکار/بی‌تفاوتی (detachment)** (به‌ظاهر سازگار، سطحی با غریبه‌ها ارتباط می‌گیرد؛ نگران‌کننده است). اقدامات: تشویق والدین به ماندن/rooming-in، آماده‌سازی والدین برای خداحافظی (نرفتن مخفیانه)، یک پرستار ثابت، وسایل آشنا (اسباب‌بازی، پتو)، حفظ روال خواب/غذا/توالت، پذیرش پسرفت (مکیدن، شب‌ادراری) و کاهش محدودیت‌ها. به‌جز جدایی: از دست دادن کنترل، آسیب بدنی، و ترس از درد.

۸ پرستاری از کودک در اختلالات آب و الکترولیت

**مقدار و نوع سرم مناسب برای درمان دهیدراتاسیون شدید در یک کودک ۱۸ ماهه با وزن ۱۴ کیلوگرم را محاسبه نمایید؟**

**پاسخ:** سرم ایزوتونیک (نرمال سالین ۰٫۹٪ یا رینگر لاکتات) ۲۰ میلی‌لیتر/کیلوگرم × ۱۴ = **۲۸۰ میلی‌لیتر** به‌صورت بولوس سریع در ۲۰–۳۰ دقیقه (قابل تکرار)

**توضیح:** در دهیدراتاسیون شدید (کاهش ۱۰٪ یا بیشتر وزن، شوک، تاکی‌کاردی، پرشدن مویرگی طولانی، چشم‌های گود، بی‌حالی، کاهش ادرار) ابتدا فاز احیا با بولوس ایزوتونیک ۲۰ mL/kg داده می‌شود و در صورت پایدار نشدن تا چند بار (تا مجموع ۶۰ mL/kg؛ یعنی ۸۴۰ mL) تکرار می‌شود. سپس مایع جایگزینی کمبود + نگهدارنده (مثلاً دکستروز ۵٪ در نیم‌نرمال یا ۰٫۲۵٪ سالین با پتاسیم بعد از دفع ادرار) طی ۲۴–۴۸ ساعت. **تکرار مثال:** سوال ۲۱ بلوپرینت ۴۰۴۲ دقیقاً همین است. نکته: دکستروز در بولوس نمی‌دهیم، پتاسیم قبل از برقراری ادرار تزریق نمی‌شود. دهیدراتاسیون خفیف/متوسط: ORS (۵۰ تا ۱۰۰ mL/kg در ۴ ساعت).

۹ پرستاری از کودک در اختلالات آب و الکترولیت

**استفاده از کدام دارو در درمان استفراغ پس از جراحی در کودکان مناسب‌تر می‌باشد؟**

**پاسخ:** اوندانسترون (آنتاگونیست گیرندهٔ ۵-HT۳)

**توضیح:** اوندانسترون (Zofran) داروی انتخابی تهوع/استفراغ پس از جراحی (PONV) و شیمی‌درمانی در کودکان است؛ عوارض: سردرد، یبوست، و (به‌ندرت) طولانی شدن QT. متوکلوپرامید و پرومتازین به دلیل عوارض اکستراپیرامیدال (دیستونی) و خواب‌آلودگی/تضعیف تنفس در کودکان کمتر ترجیح داده می‌شوند. دگزامتازون هم گاهی کمکی است. در اسهال/استفراغ ویروسی (گاستروانتریت) در کودک اوندانسترون خوراکی دوز واحد برای تحمل ORS قابل استفاده است.

۱۰ پرستاری از کودک در اختلالات کلیوی

**مهم‌ترین اقدام پرستار در مورد کودک مبتلا به تومور ویلمز کدام است؟**

**پاسخ:** لمس نکردن شکم (گذاشتن علامت «شکم را لمس نکنید» بر بالای تخت) و جابجایی با احتیاط

**توضیح:** تومور ویلمز (نفروبلاستوما) توموری کلیوی است که با توده بی‌درد و سفت یک‌طرفهٔ شکم تظاهر می‌کند. لمس عمیق یا فشار شکم می‌تواند باعث پاره شدن کپسول و انتشار سلول‌های توموری (متاستاز) شود؛ بنابراین پرستار فقط یک بار توسط پزشک معاینه می‌شود و لمس شکم ممنوع است. سایر مراقبت‌ها: اندازه‌گیری فشار خون (هیپرتانسیون به دلیل رنین)، بررسی هماچوری، شکم را هنگام حمام/جابجایی نگه نداشتن، آماده‌سازی جراحی (نفرکتومی) سپس شیمی‌درمانی ± پرتودرمانی. **تکرار:** سوال ۲۴ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۱ پرستاری از کودک در اختلالات قلبی

**اگر در معاینهٔ نوزاد متوجه نبض پر در دست‌ها و نبض آهسته (ضعیف) در پاها شدید، احتمال وجود کدام مشکل قلبی در وی مطرح می‌باشد؟**

**پاسخ:** کوآرکتاسیون آئورت (Coarctation of the Aorta)

**توضیح:** در تنگی آئورت (قسمت معمولاً بعد از انشعاب شریان ساب‌کلاوین چپ) خون به اندام فوقانی زیاد و به اندام تحتانی کم می‌رسد: **فشار خون و نبض قوی در بازوها (بالا)، نبض ضعیف/تأخیری یا نبود نبض فمورال و پاهای سرد و کم‌خون (فشار پایین).** فشار بازو ۲۰ میلی‌متر جیوه یا بیشتر از ساق بالاتر است. در نوزاد شدید: نارسایی قلبی و شوک پس از بسته شدن مجرای شریانی. درمان: جراحی/بالون آنژیوپلاستی؛ در نوزاد پروستاگلاندین E۱ برای باز نگه داشتن مجرا. اندازه‌گیری فشار خون هر چهار اندام در معاینه ضروری است. دسته‌بندی: بیماری مادرزادی غیرسیانوتیک با انسداد جریان خروجی. **تکرار:** سوال ۳۸ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۲ پرستاری از کودک در اختلالات غدد و متابولیک

**از تست کمی کلر عرق در تشخیص کدام بیماری در کودکان استفاده می‌شود؟**

**پاسخ:** فیبروز کیستیک (CF)

**توضیح:** تست عرق با روش پیلوکارپین یونتوفورز (Sweat chloride test) تست استاندارد طلایی است: کلر عرق بالای ۶۰ mEq/L (mmol/L) تشخیصی؛ ۳۰–۵۹ مرزی؛ زیر ۳۰ طبیعی. اساس: نقص ژن CFTR و دفع بیش از حد سدیم و کلر در عرق؛ پوست کودک طعم شور دارد. علائم: عفونت‌های مکرر ریه، ایلئوس مکونیوم، سوءجذب چربی، مدفوع بدبو و چرب (استئاتوره)، عدم رشد و پولیپ بینی. مراقبت: فیزیوتراپی قفسه سینه، آنزیم‌های پانکراس، رژیم پرکالری، ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K).

۱۳ پرستاری از کودک در اختلالات تنفسی

**به‌عنوان پرستار در کدام بیماری نباید اقدام به بررسی گلو یا لوله‌گذاری نمایید؟**

**پاسخ:** اپی‌گلوتیت حاد (Acute Epiglottitis)

**توضیح:** اپی‌گلوتیت: عفونت باکتریایی (Hib) و ورم شدید اپی‌گلوت؛ شروع ناگهانی با تب بالا، گلودرد شدید، آب‌ریزش دهان (drooling)، دیسفاژی، استریدور دمی، حالت سه‌پایه (tripod) و بی‌قراری. **«۴D»: Drooling، Dysphagia، Dysphonia، Distress**. هر نوع تحریک (چوب زبان، معاینهٔ گلو، خواباندن، گرفتن خون، جدا کردن از والد) می‌تواند اسپاسم حنجره و انسداد کامل راه هوایی ایجاد کند. اقدام: حفظ حالت راحت (در آغوش والد)، اکسیژن آرام، **آماده‌باش لوله‌گذاری/تراکئوستومی در اتاق عمل توسط متخصص**، آنتی‌بیوتیک وریدی (سفتریاکسون). شیوع به دلیل واکسن Hib کاهش یافته است. **تکرار:** سوال ۲۸ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۴ پرستاری از کودک در اختلالات خون

**بهترین درمان در کودک مبتلا به هموفیلی که خونریزی داخل مفصلی جدید دارد کدام است؟**

**پاسخ:** تزریق فوری فاکتور انعقادی (VIII در هموفیلی A / IX در هموفیلی B) + روش RICE (استراحت، یخ، فشار، بالا بردن عضو)

**توضیح:** خونریزی داخل مفصلی (هموآرتروز) شایع‌ترین تظاهر هموفیلی است (زانو، آرنج، مچ)؛ علائم: درد، تورم، گرمی، کاهش حرکت و حس گزگز قبل از خونریزی. اقدام اولیه: **جایگزینی فاکتور در اولین فرصت** (ترجیحاً تا ۲ ساعت)، سپس RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation) و بی‌حرکت کردن مفصل و کنترل درد با استامینوفن. **پرهیز:** آسپیرین/NSAID، تزریق عضلانی و ورزش‌های تماسی؛ DDAVP/دسموپرسین در هموفیلی A خفیف؛ ایمن‌ترین مسیر تزریقات: وریدی یا زیرجلدی. پس از کنترل خونریزی حرکت دادن آرام مفصل و فیزیوتراپی برای جلوگیری از آرتروپاتی. **تکرار:** سوال ۴۳ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۵ پرستاری از کودک در اختلالات تنفسی

**مشاهده کدام علامت در کودک مبتلا به آسم نشانهٔ هیپوکسی شدید می‌باشد و باید فوراً مداخله را آغاز کنید؟**

**پاسخ:** ساکت شدن ریه (کاهش یا قطع ویز) همراه با سیانوز و تغییر سطح هوشیاری (بی‌قراری شدید/خواب‌آلودگی)

**توضیح:** در آسم حاد، ویز نشانهٔ تنگی راه هوایی است ولی اگر ویز ناگهان قطع شود (silent chest) یعنی جریان هوا بسیار کم شده و کودک در آستانهٔ نارسایی تنفسی است. نشانه‌های هیپوکسی شدید: سیانوز، بی‌قراری یا خواب‌آلودگی/گیجی، ناتوانی در حرف زدن، استفاده از عضلات فرعی و فرورفتگی بین‌دنده‌ای، $SpO_2$ کمتر از ۹۰٪، نبض پارادوکس. اقدام: اکسیژن، آگونیست $\beta_2$ تنفسی، کورتیکواستروئید سیستمیک و آماده‌سازی انتقال به ICU. **تکرار:** سوال ۲۹ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۶ پرستاری از کودک در اختلالات گوارشی

**برای یک کودک مبتلا به هیرشپرونگ کدام رژیم غذایی را پیشنهاد می‌دهید؟**

**پاسخ:** رژیم پرکالری، پرپروتئین و کم‌فیبر (کم‌باقی‌مانده)

**توضیح:** هیرشپرونگ: فقدان سلول‌های گانگلیونی در بخشی از کولون (معمولاً رکتوسیگموئید) و انسداد عملکردی. علائم: تأخیر در دفع مکونیوم (بعد از ۴۸ ساعت)، یبوست، نفخ، مدفوع نواری شکل و بدبو، خطر انتروکولیت. قبل از جراحی: رژیم پرکالری/پرپروتئین/کم‌فیبر برای رشد و جلوگیری از انباشت مدفوع؛ شستشوی روده با سالین ایزوتونیک (نه آب ساده)، گاهی TPN. بعد از جراحی (پول‌ترو/Soave/Swenson): مراقبت از محل کولوستومی و تغذیه تدریجی. **تکرار:** سوال ۳۱ بلوپرینت ۴۰۴۲. نکتهٔ مهم: انتروکولیت (تب، اسهال انفجاری، نفخ شدید) اورژانس است.

۱۷ پرستاری از کودک در اختلالات قلبی

**در درمان باز ماندن کانال شریانی در کودک از چه داروئی استفاده می‌شود؟**

**پاسخ:** ایندومتاسین (یا ایبوپروفن / استامینوفن) برای بستن PDA

**توضیح:** مجرای شریانی (PDA) بین آئورت و شریان ریوی است که طبیعتاً چند ساعت تا چند روز بعد از تولد بسته می‌شود. داروهای مهارکنندهٔ پروستاگلاندین (ایندومتاسین یا ایبوپروفن) باعث انقباض و بسته شدن مجرا می‌شوند. عوارض ایندومتاسین: کاهش جریان خون کلیه (الیگوری، افزایش کراتینین)، هیپوناترمی، خونریزی گوارشی، کاهش پلاکت و NEC؛ باید ادرار و کراتینین را پایش کرد. اگر دارو شکست خورد: بستن با کویل/دستگاه یا جراحی. **برعکس:** در ضایعات وابسته به مجرا (مثلاً آترزی ریه، کوآرکتاسیون شدید) پروستاگلاندین E۱ (آلپروستادیل) برای باز نگه داشتن مجرا داده می‌شود. علائم PDA: سوفل ماشینی (machinery)، فشار نبض وسیع و نبض‌های جهنده. **تکرار:** سوال ۳۶ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۸ پرستاری از کودک در اختلالات قلبی

**مصرف کدام دارو همزمان با دیگوکسین احتمال مسمومیت با آن را بیشتر می‌کند؟**

**پاسخ:** دیورتیک‌های دفع‌کنندهٔ پتاسیم مثل فوروزمید (هیپوکالمی)؛ همچنین آمیودارون، وراپامیل، کینیدین

**توضیح:** دیگوکسین (گلیکوزید قلبی) با اثر اینوتروپ مثبت و کاهش ضربان کار می‌کند. شاخص درمانی باریکی دارد. عوامل افزایش خطر مسمومیت: هیپوکالمی (فوروزمید و تیازیدها)، هیپومنیزیمی، هیپرکلسمی، هیپوکسی و نارسایی کلیه؛ و مهار دفع دیگوکسین با آمیودارون، وراپامیل، کینیدین. **پرستار قبل از دادن:** نبض آپیکال یک دقیقه کامل بشمارد؛ در شیرخوار اگر کمتر از ۹۰–۱۰۰/دقیقه و در کودک کمتر از ۷۰ (یا ۶۰ در بزرگ‌تر) → دارو را نگه دارد و گزارش کند. علائم مسمومیت: برادی‌کاردی، تهوع/استفراغ، بی‌اشتهایی، اختلالات بینایی، آریتمی. دوز را دو پرستار کنترل کنند؛ دارو ۱ ساعت قبل یا ۲ ساعت بعد از غذا داده شود. **تکرار:** سوال ۴۰ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۱۹ پرستاری از کودک در اختلالات گوارشی

**در کودک مبتلا به سلیاک با آسیب مخاطی شدید مصرف کدام ماده غذایی باید حذف شود؟**

**پاسخ:** گلوتن (گندم، جو، چاودار و فرآورده‌های آنها؛ جو دوسر در صورت آلودگی)

**توضیح:** سلیاک: واکنش خودایمنی به گلیادین/گلوتن که باعث آتروفی پرزهای روده باریک و سوءجذب می‌شود. علائم: اسهال مزمن، مدفوع چرب و بدبو، نفخ، شکم بزرگ، عدم رشد، کم‌خونی فقر آهن، تحریک‌پذیری، **بحران سلیاکی** (اسهال شدید و دهیدراتاسیون). تشخیص: آنتی‌بادی tTG-IgA و بیوپسی روده. درمان: رژیم بدون گلوتن مادام‌العمر، مصرف برنج، ذرت، سیب‌زمینی، سبزی و میوه، گوشت، لبنیات. مکمل‌های آهن، فولات، کلسیم و ویتامین D و B۱۲ ممکن است لازم باشد. آموزش خواندن برچسب مواد غذایی، پرهیز از آلودگی متقابل. **تکرار:** سوال ۳۴ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۰ پرستاری از کودک در اختلالات کلیوی

**مادری از شما در مورد مراقبت در منزل کودک ۷ ساله مبتلا به سندرم نفروتیک سوال می‌کند، کدام پاسخ صحیح است؟**

**پاسخ:** کنترل روزانه ادرار با نوار (پروتئین) و پرهیز از تماس با عفونت؛ قطع نکردن ناگهانی پردنیزولون؛ رژیم کم‌نمک هنگام ادم

**توضیح:** سندرم نفروتیک: پروتئین‌اوری شدید (>۴۰ mg/m²/h)، هیپوآلبومینمی، ادم (دور چشم صبح، شکم، اسکروتوم) و هیپرلیپیدمی. شایع‌ترین نوع در کودکان: تغییرات حداقل (MCNS) و پاسخ به استروئید. **آموزش به مادر:** ۱) اندازه‌گیری روزانه پروتئین ادرار با نوار آزمایش (ادرار صبح اول) و ثبت؛ پروتئین ۳+ یا ۴+ برای ۳ روز متوالی = عود؛ ۲) **پردنیزولون را ناگهانی قطع نکنید** (نارسایی آدرنال) و عوارضش (چاقی، صورت ماه‌گرفته، فشار خون، تغییر خلق، خطر عفونت) را بدانید؛ ۳) پیشگیری از عفونت (خطر بالا) و مراجعه سریع با تب؛ واکسن زنده در زمان مصرف دوز بالای استروئید تزریق نشود؛ ۴) رژیم: کم‌نمک (فقط در دورهٔ ادم)، محدودیت پروتئین لازم نیست؛ ۵) وزن روزانه و دور شکم. فعالیت: طبق تحمل. **تکرار:** سوال ۲۶ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۱ پرستاری از کودک در اختلالات قلبی

**در کدام عیب مادرزادی قلب شیرخوار احتمال بروز حملات حاد سیانوز و هیپوکسی (blue/tet spells) وجود دارد و باید به والدین آموزش داده شود؟**

**پاسخ:** تترالوژی فالو (Tetralogy of Fallot)

**توضیح:** تترالوژی فالو چهار عیب دارد: VSD، تنگی ریوی، دکستراپوزیشن (سوار شدن) آئورت، هیپرتروفی بطن راست. شانت راست به چپ ← سیانوز. حملهٔ هیپرسیانوتیک (Tet spell) هنگام گریه، تغذیه، مدفوع یا بیداری رخ می‌دهد؛ علائم: سیانوز ناگهانی، تنفس عمیق و سریع، بی‌قراری، شل شدن و حتی از دست دادن هوشیاری. **اقدام والدین/پرستار:** (۱) در آغوش گرفتن و آرام کردن، (۲) وضعیت زانو–سینه (Knee-chest) یا خوابیدن روی پهلو با پاها خم (افزایش مقاومت عروق محیطی و بازگشت وریدی)، (۳) اکسیژن، (۴) مورفین تزریقی (کاهش ناراحتی/تنفس)، (۵) مایع وریدی، و پزشک ممکن است بتابلوکر (پروپرانولول) بدهد. مراقبت دیگر: پیشگیری از دهیدراتاسیون، چماق انگشتان، اجتناب از گریهٔ طولانی. **تکرار:** سوال ۳۷ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۲ پرستاری از کودک در اختلالات گوارشی

**کدام گزینه در مورد تنگی هیپرتروفیک پیلور صحیح می‌باشد؟**

**پاسخ:** استفراغ فوّاره‌ای بدون صفرا، توده زیتونی‌شکل در اپیگاستر/ربع راست فوقانی و امواج پریستالسیس قابل مشاهده؛ آلکالوز متابولیک هیپوکلرمیک و هیپوکالمیک

**توضیح:** هیپرتروفی عضلهٔ پیلور باعث انسداد خروجی معده می‌شود؛ شایع‌تر در پسران (۴:۱) و فرزند اول، بین ۲–۸ هفتگی. علائم: استفراغ پرتابی (projectile) بدون صفرا بعد از شیر، شیرخوار گرسنه و حریص، کاهش وزن، دهیدراتاسیون، امواج پریستالتیک از چپ به راست و «زیتون» لمس‌شدنی. آزمایش: آلکالوز متابولیک (کاهش Cl و K)، سونوگرافی (ضخامت عضله ≥ ۴ mm، طول ≥ ۱۴–۱۶ mm). درمان: ابتدا اصلاح آب و الکترولیت (NPO و مایع وریدی) و سپس **پیلورومیوتومی**؛ بعد عمل شروع تغذیه با مقدار کم و تدریجی. **تکرار:** سوال ۳۳ بلوپرینت ۴۰۴۲ (یافتهٔ شایع).

۲۳ پرستاری از کودک در اختلالات قلب

**در حین ساکشن کردن شیرخوار مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بروز کدام علامت نشان‌دهندهٔ تحریک واگ می‌باشد؟**

**پاسخ:** برادی‌کاردی (کاهش ضربان قلب)

**توضیح:** ساکشن راه هوایی و تحریک حلق/نای عصب واگ را تحریک کرده و باعث برادی‌کاردی، افت فشار و گاهی آپنه می‌شود؛ هیپوکسی هم ایجاد می‌کند. در شیرخوار قلبی که ذخیرهٔ کم دارد خطر بیشتر است. **پیشگیری:** قبل و بعد از ساکشن اکسیژن، مدت ساکشن ≤ ۱۰ ثانیه، پایش مانیتور ECG/SpO۲، توقف فوری در صورت افت ضربان یا اشباع. تکرار: سوال ۴۱ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۴ پرستاری از کودک در اختلالات گوارشی

**پرستار با مشاهده کدام علامت در کودک متوجه بهبودی در هم‌فرورفتگی روده (اینتوساسپشن) می‌شود و باید فوراً گزارش کند؟**

**پاسخ:** دفع مدفوع طبیعی قهوه‌ای (بازگشت مدفوع طبیعی) و کاهش درد/نفخ

**توضیح:** اینتوساسپشن: فرو رفتن قطعه‌ای از روده در قسمت بعدی (شایع‌ترین ایلئوکولیک)، ۳ ماه تا ۳ سال. علائم: حملات ناگهانی درد کولیکی شکم با زانو به شکم جمع شدن، استفراغ، توده سوسیسی در شکم، **مدفوع ژله‌ای/قرنفلی خونی «کشمش‌دار» (currant jelly)**. درمان: تنقیهٔ هوا یا باریم تحت فلوروسکوپی/سونوگرافی، در صورت شکست یا سوراخ‌شدگی جراحی. علامت موفقیت درمان یا باز شدن خودبه‌خودی: **دفع مدفوع طبیعی قهوه‌ای + از بین رفتن درد**؛ پرستار مدفوع‌ها را بررسی و گزارش می‌کند. نشانهٔ بد: شل شدن، تب، پریتونیت. **تکرار:** سوال ۳۲ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۵ پرستاری از کودک در اختلالات قلبی

**کدام علامت از معیارهای کلاسیک کاوازاکی نمی‌باشد؟**

**پاسخ:** ملتحمهٔ چرکی/اگزوداتیو، بثورات تاولی، لنفادنوپاتی ژنرالیزه، اگزودای حلق (و ... آنوریسم عروق کرونر که «عارضه» است نه معیار)

**توضیح:** ملاک‌های تشخیصی: تب ≥۵ روز + حداقل ۴ مورد از ۵ علامت: ۱) ملتحمهٔ دوطرفه غیرچرکی (بدون ترشح)؛ ۲) تغییرات دهان و لب (لب قرمز و ترک‌دار، زبان توت‌فرنگی، قرمزی حلق)؛ ۳) بثورات پلی‌مورف (غیرتاولی)؛ ۴) تغییرات اندام‌ها (قرمزی و ادم کف دست/پا، پوسته‌ریزی سه هفته‌ای انگشت)؛ ۵) لنفادنوپاتی گردنی یک‌طرفه ≥۱٫۵ سانتی‌متر. عارضهٔ اصلی: آنوریسم عروق کرونر. درمان: IVIG (۲ g/kg) + آسپیرین. ⚠ چون گزینه‌های آزمون در بلوپرینت نیامده، این پاسخ شامل مواردی است که معیار نیستند. واکسن زنده (MMR/آبله‌مرغان) تا ۱۱ ماه بعد از IVIG به تعویق می‌افتد. آسپیرین در زمان آنفولانزا/آبله‌مرغان خطر سندرم ری دارد؛ واکسن آنفولانزای غیرزنده توصیه می‌شود. **تکرار:** سوال ۳۹ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۶ پرستاری از کودک در اختلالات خون

### هدف از اسپلنکتومی در کودک مبتلا به تالاسمی چیست؟

**پاسخ:** کاهش تخریب گلبول‌های قرمز و نیاز به تزریق خون در اسپلنومگالی/هیپراسپلنیسم

**توضیح:** در تالاسمی ماژور (بتا) نقص ساخت زنجیرهٔ بتا گلوبین و کم‌خونی شدید؛ بیمار نیاز به انتقال خون مکرر دارد و طحال بزرگ می‌شود و گلبول‌های قرمز را بیشتر از حد می‌شکند (هیپراسپلنیسم) و نیاز به خون را بالا می‌برد. اسپلنکتومی برای کاهش نیاز تزریق خون و راحتی بیمار است (معمولاً بعد از ۵ سالگی). **عوارض و آموزش:** افزایش خطر عفونت‌های شدید (OPSI) توسط باکتری‌های کپسول‌دار (پنوموکوک، هموفیلوس، منینگوکوک)؛ واکسیناسیون پیش از جراحی و پنی‌سیلین پروفیلاکسی. درمان‌های دیگر: انتقال خون منظم، دفروکسامین/دفراسیروکس (شلاسیون آهن)، فولیک اسید، پیوند مغز استخوان. **تکرار موضوعی:** سوال ۴۲ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۲۷ پرستاری از کودک در اختلالات تنفسی

### کدامیک از داروهای زیر در درمان آسم حاد اولویت دارد؟

**پاسخ:** آگونیست کوتاه‌اثر بتا۲ استنشاقی (سالبوتامول/آلبوترول) — برونکودیلاتور سریع‌الاثر

**توضیح:** آسم حاد: اولین خط درمان SABA (سالبوتامول با نبولایزر یا اسپیسر) هر ۲۰ دقیقه تا ۳ بار؛ سپس کورتیکواستروئید سیستمیک (پردنیزولون/دگزامتازون/هیدروکورتیزون) و اکسیژن؛ در موارد شدید ایپراتروپیوم، منیزیم سولفات وریدی و در نهایت ICU. داروهای کنترلی (نگهدارنده): کورتیکواستروئید استنشاقی (بودزونايد/فلوتیکازون)، مونته‌لوکاست، LABA همراه با ICS. فرق: داروی «نجات» (SABA) در حمله و داروی «کنترل‌کننده» برای پیشگیری. عوارض سالبوتامول: تاکی‌کاردی، لرزش، هیپوکالمی. مراقبت: اکسیژن برای SpO۲ ≥۹۰–۹۴٪، نشستن، مایعات و آموزش استفاده از اسپیسر و دهان‌شویی بعد از استروئید استنشاقی (پیشگیری از برفک).

۲۸ پرستاری از کودک در اختلالات عصبی

### کودک تحت درمان با فنی‌توئین نیاز به دریافت کدام مکمل زیر را دارد؟

**پاسخ:** فولیک اسید (و در مصرف طولانی ویتامین D)

**توضیح:** فنی‌توئین (دیلانتین) جذب فولات را کم می‌کند و می‌تواند باعث کم‌خونی مگالوبلاستیک شود؛ ویتامین D و K نیز ممکن است کاهش یابد. عوارض مهم: هیپرپلازی لثه (بهداشت دهان، مسواک نرم، دندان‌پزشکی منظم)، هیرسوتیسم، آتاکسی، نیستاگموس، راش (سندرم استیونس–جانسون)، سطح درمانی خون ۱۰–۲۰ µg/mL. در تزریق وریدی ریسک آریتمی و افت فشار (سرعت ≤ ۱ mg/kg/min) و در بافت اطراف نکروز (قرمز و بنفش). نکتهٔ مصرف: دارو را ناگهانی قطع نکنید (وضعیت صرع). با لوله گاواژ جذب کم می‌شود.

۲۹ پرستاری از کودک در اختلالات عصبی

**بهترین وضعیت جهت تغذیهٔ کودک مبتلا به فلج مغزی کدام است؟**

**پاسخ:** نشسته (بالای ۴۵–۹۰ درجه) با سر در خط وسط و کمی خم به جلو (چانه به سمت قفسهٔ سینه)، تنه و لگن خم

**توضیح:** در فلج مغزی (CP) مشکلات بلع، رفلاکس معده–مری، آسپیراسیون و اسپاستیسیته وجود دارد. وضعیت مناسب: نشسته و صاف، سر در راستای خط وسط، گردن کمی خم (چانه به سمت سینه)، شانه‌ها به جلو، لگن خم؛ پس از غذا ۳۰–۶۰ دقیقه در همان حالت بماند. هیپراکستانسیون گردن (سر به عقب) باعث آسپیراسیون است. غذا: غلیظ و نرم (نه مایع رقیق)، قاشق کوچک، زمان کافی، حمایت از لب/فک؛ در صورت شدید بودن گاستروستومی. تغذیهٔ پرکالری (کالری مورد نیاز بالاتر در CP). تکرار موضوعی: سوال ۴۶ بلوپرینت ۴۰۴۲ (دانترولن).

۳۰ پرستاری از کودک در اختلالات غدد و متابولیک

**رعایت کدام مورد زیر را برای مراقبت گوارشی در یک کودک مبتلا به فیبروز کیستیک توصیه می‌کنید؟**

**پاسخ:** مصرف آنزیم‌های پانکراس با هر وعده و میان‌وعده (بلافاصله قبل/همراه غذا)؛ رژیم پرکالری–پرپروتئین؛ مکمل ADEK و نمک

**توضیح:** در CF مجاری پانکراس با ترشحات غلیظ مسدود شده و آنزیم‌ها به روده نمی‌رسند؛ نتیجه سوءجذب چربی/پروتئین، استئاتوره، شکم بزرگ و عدم رشد. درمان: ۱) آنزیم‌های پانکراس (پانکرلیپاز) همراه هر وعده غذا و میان‌وعده (۳۰ دقیقه اول وعده)؛ کپسول سالم بلعیده شود (نجوید و له نشود)؛ در شیرخوار محتویات کپسول روی غذای اسیدی (سیب پخته) پاشیده می‌شود؛ ۲) رژیم پرکالری (۱۲۰–۱۵۰٪ نیاز)، پرپروتئین و چرب بدون محدودیت چربی؛ ۳) مکمل ویتامین‌های محلول در چربی (A, D, E, K) به شکل محلول در آب؛ ۴) مصرف نمک اضافی در هوای گرم و تب. دوز آنزیم با کیفیت مدفوع (کاهش چربی، عدم نفخ) تنظیم می‌شود. **تکرار:** سوال ۴۷ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۳۱ پرستاری از کودک در اختلالات غدد و متابولیک

**برای درمان دهیدراتاسیون در کتواسیدوز دیابتی از کدام محلول در اورژانس استفاده می‌کنید؟**

**پاسخ:** نرمال سالین ۰٫۹٪ (ایزوتونیک) با سرعت آهسته؛ بولوس ۱۰–۲۰ mL/kg در یک ساعت اول

**توضیح:** DKA: هیپرگلیسمی، کتونمی، اسیدوز (HCO۳ <۱۵ / pH <۷.۳)، دهیدراتاسیون. درمان: ابتدا مایع ایزوتونیک (NS یا رینگر لاکتات) ۱۰–۲۰ mL/kg در ۱ ساعت اول و سپس تعدیل مایع طی ۴۸ ساعت (به‌آهستگی برای پیشگیری از ادم مغزی)، **انفوزیون انسولین رگولار ۰٫۰۵–۰٫۱ واحد/kg/h پس از ۱ ساعت مایع**، افزودن پتاسیم (KCl یا K-فسفات) بعد از ادرار کردن و تأیید پتاسیم، و افزودن دکستروز وقتی قند <۲۵۰–۳۰۰. هرگز بولوس انسولین ندهید و بی‌کربنات معمولاً ندهید. پایش: قند هر ساعت، الکترولیت، وضعیت نورولوژیک (سردرد، استفراغ، برادی‌کاردی = ادم مغزی). **تکرار:** سوال ۴۸ بلوپرینت ۴۰۴۲.

۳۲ تنیدگی بستری شدن

**کودک ۲۴ ماههٔ که از تماس با افراد غریبه امتناع می‌کند، کدام مرحله اضطراب جدایی را نشان می‌دهد؟**

**پاسخ:** مرحلهٔ اعتراض (Protest)

**توضیح:** اعتراض: گریه شدید، صدا زدن والدین، چنگ زدن، رد غریبه‌ها و پرخاش (ممکن است ساعت‌ها تا روزها ادامه یابد). ناامیدی (Despair): گریهٔ آرام، بی‌حالی، کناره‌گیری، کاهش اشتها و فعالیت. انکار/بی‌تفاوتی (Detachment): در ظاهر سازگار است و با غریبه‌ها سطحی ارتباط برقرار می‌کند ولی در واقع به والدین بی‌علاقه است (علامت خطر). توضیح کامل سه مرحله در سوال ۷ همین بلوپرینت آمده است.

۳۳ پرستاری از کودک در اختلالات ایمنولوژیک

**کدام تست آزمایشگاهی تأییدکنندهٔ پورپورای ایدیوپاتیک (ITP) در کودک می‌باشد؟**

**پاسخ:** شمارش پلاکت (ترومبوسیتوپنی شدید) با سایر ردهٔ سلولی طبیعی؛ مغز استخوان برای رد لوسمی (مگاکاریوسیت طبیعی یا زیاد)

**توضیح:** ITP: تخریب ایمنی پلاکت‌ها (معمولاً ۱–۴ هفته پس از عفونت ویروسی یا واکسن). علائم: پتشی و کبودی ناگهانی در کودک سالم، خونریزی لثه/بینی، پلاکت <۱۰۰ هزار (اغلب <۲۰ هزار)؛ هموگلوبین و WBC و PT/PTT طبیعی، اسپلنومگالی ندارد. تشخیص: CBC (پلاکت کم) + اسمیر خون؛ آسپیراسیون مغز استخوان فقط در موارد مشکوک به لوسمی/نارسایی مغز استخوان (مگاکاریوسیت زیاد یا طبیعی). درمان: اغلب خودمحدود در ۶ ماه؛ IVIG، پردنیزولون، Anti-D؛ اجتناب از آسپیرین/NSAID/تزریق عضلانی/فعالیت‌های پرخطر. **پرستار:** جلوگیری از ضربه، مسواک نرم، فشار طولانی بعد از تزریق.

۳۴ پرستاری از کودک در اختلالات آب و الکترولیت

**دو عارضه جدی اسهال حاد در کودکان چیست؟**

**پاسخ:** دهیدراتاسیون شدید (شوک هیپوولمیک) و اختلال الکترولیت/اسیدوز متابولیک

**توضیح:** در اسهال حاد از دست رفتن آب، سدیم، پتاسیم و بی‌کربنات رخ می‌دهد: **دهیدراتاسیون** (ایزوتونیک شایع‌ترین، هیپرتونیک و هیپوتونیک) ← شوک هیپوولمیک و نارسایی کلیه؛ **اسیدوز متابولیک** (از دست رفتن بی‌کربنات) با تنفس عمیق و تند (کوسمال)؛ **هیپوکالمی** با ضعف/آریتمی؛ **هیپرناترمی** در دهیدراتاسیون هیپرتونیک با تشنج. شواهد دهیدراتاسیون: نبض ضعیف و تند، پرشدن مویرگی >۲ ثانیه، فونتانل گود، کاهش اشک/ادرار، پوست با ترگور کم. درمان: ORS (خفیف/متوسط)، مایع وریدی (شدید)، ادامهٔ تغذیه/شیر مادر، زینک ۱۰–۲۰ mg/day، ارزش اندک آنتی‌بیوتیک/ضداسهال. پیشگیری: واکسن روتاویروس، شست‌وشوی دست و آب آشامیدنی سالم. تکرار موضوعی: سوال ۸ همین بلوپرینت.

# بخش سوم: بلوپرینت نیمسال دوم (۴۰۴۲) — ۴۸ سوال

۱ نوزاد پرخطر و خانواده

**کدام شاخص، دقیق‌ترین معیار برای ارزیابی کفایت مایع‌رسانی در نوزاد نارس است؟**

**پاسخ:** وزن روزانه (ترجیحاً با یک ترازو و بدون لباس) در کنار حجم ادرار (۱ تا ۳ mL/kg/h) و وزن مخصوص ادرار (۱٫۰۰۲–۱٫۰۱۲)

**توضیح:** نوزاد نارس به دلیل پوست نازک، سطح بدن نسبتاً بزرگ و دفع غیرمحسوس آب بالا (که با گرمای تابشی و فتوتراپی بیشتر می‌شود) به‌سرعت دچار دهیدراتاسیون می‌شود؛ اما در روزهای اول تولد کاهش وزن ۱۰–۱۵٪ فیزیولوژیک است. **دقیق‌ترین شاخص عملی تغییر وزن روزانه است** (دقت ۵–۱۰ گرم؛ هر تغییر ناگهانی به معنی تغییر مایع). شاخص‌های تکمیلی: برون‌ده ادراری، وزن مخصوص ادرار، سدیم سرم، فونتانل، رنگ و ترگور پوست، فشارخون و I&O دقیق. نکته: نوزاد نارس خیلی کم‌وزن مستعد هیپرناترمی (دهیدراتاسیون) و در مقابل ازدیاد مایع (IVH، NEC، BPD، PDA) است؛ بنابراین مایع‌درمانی دقیق با پمپ و پایش لازم است.

۲ نوزاد پرخطر و خانواده

**پرستار برای مراقبت بینایی یک نوزاد نارس، کدام اقدام را باید در اولویت قرار دهد؟**

**پاسخ:** کنترل نور محیط (نور ملایم، پوشش انکوباتور) و پایش اکسیژن ($SpO_2$ هدف ۹۰–۹۵٪) برای پیشگیری از ROP، همراه با غربالگری چشم

**توضیح:** رتینوپاتی نارسی (ROP) در نوزادان زیر ۳۰ هفته/۱۵۰۰ گرم به علت نارسی عروق شبکیه و هیپراکسی رخ می‌دهد. پرستار: (۱) تنظیم دقیق اکسیژن با اکسی‌متر و اجتناب از هیپراکسی/افت‌وخیز؛ (۲) نور ملایم، چرخهٔ شب و روز و پوشاندن چشم‌ها هنگام فتوتراپی؛ (۳) برنامه‌ریزی غربالگری افتالموسکوپی ۴–۶ هفتگی یا ۳۱ هفتگی پس از لقاح؛ (۴) حفاظت از چشم‌ها هنگام معاینات و استفاده از قطره ضد عفونی. درمان: لیزر، تزریق داخل زجاجیه (Anti-VEGF) و جراحی.

۳ نوزاد پرخطر و خانواده

**کدام تغییر رفتاری در نوزاد می‌تواند از تظاهرات اولیه سپسیس باشد؟**

**پاسخ:** بی‌حالی/کاهش فعالیت، بی‌میلی به شیر خوردن (تغذیه ضعیف) و تحریک‌پذیری — «not doing well»

**توضیح:** علائم سپسیس نوزادی بسیار غیراختصاصی‌اند: **رفتاری:** لتارژی، کاهش فعالیت و تونوس، بی‌علاقگی به تغذیه، تحریک‌پذیری؛ **تنفسی:** آپنه، تاکی‌پنه؛ **قلبی:** برادی‌کاردی/تاکی‌کاردی، افت فشار؛ **دمایی:** بی‌ثباتی (تب یا هیپوترمی)؛ **پوست:** رنگ‌پریدگی، خاکستری شدن، پتشی؛ **گوارشی:** باقی‌مانده‌ی معده، نفخ؛ **متابولیک:** هیپوگلیسمی/اسیدوز. عامل شایع: استرپتوکوک گروه B و E. coli (زودرس)، استافیلوکوک (دیررس). درمان: کشت‌ها، آنتی‌بیوتیک وریدی (آمپی‌سیلین + جنتامایسین) و حمایت. پیش‌آگهی بد: لکوپنی (به سوال ۲ میان‌ترم مراجعه شود).

۴ نوزاد پرخطر و خانواده

**در مراقبت از نوزاد مبتلا به انتروکولیت نکروزان (NEC)، در صورت بروز نفخ شکم، پرستار کدام اقدام را در اولویت قرار می‌دهد؟**

**پاسخ:** قطع تغذیه (NPO) + گذاشتن سوند معده (NG/OG) برای تخلیه با ساکشن ملایم و گزارش به پزشک؛ اندازه‌گیری دور شکم

**توضیح:** NEC نکروز التهابی روده است (بیشتر در نارس): عوامل خطر: نارسی، هیپوکسی/ایسکمی روده، تغذیهٔ شیر مصنوعی و باکتری‌ها. علائم: نفخ و حساسیت شکم، باقی‌ماندهٔ معده سبز/صفراوی، استفراغ، خون در مدفوع، بی‌حالی، برادی‌کاردی/آپنه. اولین قدم: **NPO + تخلیه معده**، مایع وریدی/TPN، آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف، پایش ثبت دور شکم هر ۴–۸ ساعت و رادیوگرافی (پنوماتوز روده‌ای، هوای ورید پورت، پنوموپریتونه = پرفوراسیون ← جراحی). پیشگیری: شیر مادر، شروع آهسته تغذیه، پروبیوتیک. تکرار موضوعی: سوال ۱۶ میان‌ترم.

۵ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف سوال تکراری

**نوزادی که در اولین تغذیه دهانی دچار استفراغ، آسپیراسیون، سرفه و سیانوز می‌شود چه تشخیصی برای وی مطرح است؟**

**پاسخ:** آترزی مری با فیستول تراکئوازوفاژیال (EA/TEF)

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۴ فایل میان‌ترم؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است. خلاصه: سرفه، خفگی و سیانوز با شروع تغذیه + ترشح کف‌آلود دهان؛ عدم عبور سوند NG؛ NPO، سر بالا، ساکشن Replogle و جراحی؛ بررسی VACTERL.

۶ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف سوال تکراری

**کدام یک از علائم زیر نشان‌دهندهٔ انسداد شانت بطنی–صفاقی در شیرخوار مبتلا به هیدروسفالی می‌باشد؟**

**پاسخ:** تحریک‌پذیری، برآمدگی و تنش فونتانل، استفراغ، خواب‌آلودگی

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۰ فایل میان‌ترم؛ توضیح کامل آنجا آمده است. خلاصه: انسداد شانت یعنی افزایش ICP: فونتانل برجسته، تحریک‌پذیری، استفراغ، لتارژی، چشم غروب‌کننده، افزایش دور سر؛ اقدام: گزارش فوری.

۷ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف سوال تکراری

**در شیرخوار مبتلا به مننگومیلوسل برای رفع احتباس ادراری به دلیل مثانه نوروژنیک اقدام مناسب کدام است؟**

**پاسخ:** سونداژ متناوب تمیز با سوند نلاتون (CIC)

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۸ فایل میان‌ترم؛ توضیح آنجا نوشته شده است. خلاصه: CIC روش انتخابی؛ سوند فولی دائم خطر UTI؛ Credé ممنوع/غیرانتخابی؛ وسایل بدون لاتکس.

۸ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**کدام اقدام در بررسی کودکان مبتلا به پای چماقی ضروری است؟**

**پاسخ:** بررسی ناهنجاری‌های همراه (لگن/ستون فقرات) و اینکه آیا پا «انعطاف‌پذیر» است یا «سفت»؛ پایش وضعیت عصبی–عروقی پا بعد از گچ

**توضیح:** پای چماقی (Talipes equinovarus): ۴ مؤلفه (کاووس، آداکشن، واروس، اکوینوس). ضروری است قبل از درمان: (۱) معاینهٔ لگن برای DDH و ستون فقرات/عصب (مننگومیلوسل، آرتروديپلازی)؛ (۲) امتحان سفتی (آیا با دست به وضعیت طبیعی می‌رسد؟) — اگر آری یعنی «پوزیشنال» و درمان آسان؛ سفتی یعنی چماقی واقعی. درمان Ponseti: گچ‌گیری هفتگی با تغییر وضعیت پا، تنوتومی آشیل، و بریس (Denis-Browne) تا ۴–۵ سالگی. **پرستار:** بعد از گچ، بررسی رنگ، دما، پرشدن مویرگی، حس و حرکت انگشتان، بالا نگه داشتن پا و آموزش مراقبت از گچ؛ علائم سندرم کمپارتمان. تکرار موضوعی: سوال ۱۲ میان‌ترم.

۹ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**شیرخوار ۴۵ روزه‌ای با شک به دیسپلازی مفصل ران برای ارزیابی مراجعه کرده است. مناسب‌ترین اقدام تشخیصی کدام است؟**

**پاسخ:** سونوگرافی مفصل ران (Hip ultrasound)

**توضیح:** تا حدود ۴–۶ ماهگی هستهٔ استخوانی سر فمور هنوز استخوانی نشده و فقط غضروفی است و رادیوگرافی ارزش ندارد؛ بنابراین سونوگرافی (روش Graf/دینامیک) بهترین ابزار تشخیصی است. بعد از ۴–۶ ماهگی رادیوگرافی لگن (AP) ارزش پیدا می‌کند. علائم بالینی: تست‌های ارتولانی (کلیک ورود) و بارلو (دررفتگی با فشار) در نوزادان، علامت گالیازی/الیس، چین‌های نامتقارن ران، محدودیت ابداکشن (بعد از ۳ ماهگی) و ترندلنبرگ در کودک راه‌رونده. درمان: بند Pavlik (۰–۶ ماه، شب و روز ۲۴ ساعته)، اگر شکست خورد گچ اسپایکا/جراحی. **پرستار:** آموزش نحوهٔ پوشاندن (لباس زیر بند)، اصلاح پوست زیر بند و عدم تنظیم بند توسط والدین. تکرار موضوعی: سوال ۱۱ میان‌ترم.

۱۰ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**پس از جراحی ترمیم شکاف لب، از کدام اقدام باید اجتناب شود؟**

**پاسخ:** هر کاری که فشار/کشش به خط بخیه وارد کند: خوابیدن روی شکم، مکیدن (پستانک/شیشه)، گذاشتن چیز در دهان (قاشق/نی)، گریهٔ طولانی و دست‌زدن به محل زخم

**توضیح:** بعد از شیلوپلاستی (۳ ماهگی تقریباً): وضعیت صحیح به پشت یا نیمه‌نشسته در صندلی شیرخوار؛ بازوها با آرنج‌بند (restraint) ولی ۱–۲ بار در روز باز شود؛ تغذیه با قاشق/قطره‌چکان/سرنگ بدون نوک، ساده و آرام؛ تمیز کردن خط بخیه بعد از هر تغذیه با سرم فیزیولوژی یا آب‌اکسیژنه رقیق (طبق دستور)، پمادهای آنتی‌بیوتیک، کنترل درد؛ جلوگیری از گریه (آرام کردن، پاسخ‌گویی سریع). **بعد از جراحی شکاف کام** (۹–۱۸ ماهگی): دمر یا پهلو، عدم گذاشتن هیچ جسم در دهان (چوب بستنی، مسواک، قاشق، پستانک)، رژیم مایع/نرم و ... (به سوال ۱۴ میان‌ترم مراجعه شود). عارضه: عفونت گوش میانی (اوتیت)، مشکلات گفتاری و دندانی.

۱۱ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**نوزادی با امفالوسل بزرگ بستری شده است و به دلیل شرایط بالینی، جراحی به تعویق افتاده است. کدام اقدام پرستاری مناسب‌تر است؟**

**پاسخ:** پوشاندن کیسه با گاز استریل مرطوب با سالین گرم + پوشش پلاستیکی، حفظ حرارت و جلوگیری از پارگی/فشار کیسه

**توضیح:** امفالوسل: ناف فتقی با کیسه‌ای از پریتوان و آمنیون (برخلاف گاستروشیزی بدون کیسه) که حاوی روده/کبد است و غالباً با سایر ناهنجاری‌ها (قلبی، بکویث–ویدمان، کروموزومی) همراه است. **اگر جراحی تأخیر داشت:** (۱) پوشاندن کیسه با گاز مرطوب سالین گرم و پلاستیک شفاف (کاهش اتلاف مایع و حرارت)؛ (۲) گرم نگه داشتن نوزاد در انکوباتور/گرم‌کننده؛ (۳) قرار دادن نوزاد به پهلو یا نیمه‌خوابیده با حمایت کیسه (بدون فشار/کشش)؛ (۴) NPO و NG با ساکشن؛ (۵) مایع وریدی و آنتی‌بیوتیک؛ (۶) مراقبت از پارگی کیسه (اورژانس)؛ (۷) پایش دما و قند (هیپوگلیسمی بکویث). درمان نهایی ترمیم یک‌مرحله‌ای یا مرحله‌ای (Silo). تکرار موضوعی: سوال ۶ میان‌ترم (ادم اندام تحتانی).

۱۲ تنیدگی بستری شدن

**به عنوان پرستار، در مراقبت از کودک خردسال (پیش‌دبستانی) بستری در بیمارستان، به کدام نکته باید بیشتر توجه کنید؟**

**پاسخ:** ترس از آسیب/صدمهٔ بدنی و تنبیه (تفکر جادویی)؛ همراه با حضور والدین، توضیح ساده و بازی‌درمانی

**توضیح:** پیش‌دبستانی (۳–۶ سال): اضطراب جدایی کمتر از نوپا است ولی ترس از صدمه به بدن (ختنه، تزریق، «شکافتن»)، ترس از تاریکی و تنبیه (بیماری را پیامد بدی خود می‌داند)، پسرفت و از دست دادن کنترل. اقدامات: آماده‌سازی کوتاه‌مدت با عروسک و بازی بلافاصله قبل از اقدام، توضیح با زبان ساده «این دارو کمک می‌کند، تقصیر تو نیست»، فرصت انتخاب‌های کوچک، تشویق بازی و ابراز احساسات، حضور والدین، پاداش و اجازهٔ گریه. برای نوپا (سوال ۷ بلوپرینت ۴۰۴۱) مهم‌ترین مسئله اضطراب جدایی بود؛ برای پیش‌دبستانی ترس از آسیب بدنی. تکرار موضوعی: سوال ۳ و ۷ بلوپرینت ۴۰۴۱.

۱۳ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**کودکی یک هفته پس از جراحی ارکیوپکسی (فرود بیضه) برای ویزیت مراجعه کرده است. والدین درباره استفاده از سه‌چرخه سؤال می‌کنند. پرستار کدام پاسخ را می‌دهد؟**

**پاسخ:** تا مدتی (حدود ۲ تا ۴ هفته، تا اجازهٔ جراح) از سه‌چرخه و وسایل سواری‌شدنی/نشستنِ «دوپا آویزان» استفاده نکند

**توضیح:** ارکیوپکسی: درمان بیضهٔ نزول‌نکرده (کریپتورکیدیسم) معمولاً بین ۶–۱۲ ماهگی (حداکثر تا ۱۸ ماهگی) برای حفظ باروری و کاهش خطر سرطان. بعد از عمل: پرهیز از فشار روی محل (سه‌چرخه، دوچرخه، اسب‌های سواری، پریدن) حدود ۲ هفته یا طبق دستور جراح؛ کنترل خونریزی/تورم/عفونت زخم؛ مراقبت از پانسمان و حمام آرام. در صورت قرمزی یا ترشح، تب، تورم یا درد شدید به پزشک مراجعه شود. خطر بالقوهٔ آتروفی بیضه.

۱۴ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**در صورت نیاز به تهیهٔ نمونهٔ ادرار از شیرخوار مبتلا به اکستروفی مثانه، کدام روش توصیه می‌شود؟**

**پاسخ:** جمع‌آوری از دهانهٔ حالب‌ها با ظرف استریل یا سوند باریک استریل (روش استریل)؛ پرهیز از کیسهٔ چسبان روی مخاط

**توضیح:** اکستروفی مثانه: مخاط مثانه به‌صورت باز و در سطح شکم (دیواره شکم و پوبیس بسته نشده) دیده می‌شود؛ شیرخوار بی‌اختیاری و خطر عفونت دارد. مراقبت: مخاط را با پوشش غیرچسبنده و پلاستیک شفاف (نه گاز مرطوب) بپوشانید و با سالین نرم شست‌وشو دهید؛ پوشش را مرتب عوض کنید؛ به پوست اطراف کرم محافظ بزنید؛ از لاتکس و تماس خشن پرهیز کنید؛ نمونهٔ ادرار با رعایت استریل از دهانهٔ حالب یا از «چکیدن» داخل ظرف استریل؛ آنتی‌بیوتیک پروفیلاکسی. درمان جراحی ترمیم در ۴۸–۷۲ ساعت اول تا ماه‌ها بعد. ⚠ اگر در جزوهٔ استاد روش خاصی (مثل سوند نلاتون) ذکر شده، همان را مبنا بگیرید.

۱۵ نوزاد با مشکلات متابولیک

**کدام ماده غذایی برای کودک مبتلا به فنیل‌کتونوری باید محدود شود؟**

**پاسخ:** غذاهای پرپروتئین/دارای فنیل‌آلانین (گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، لبنیات، حبوبات، آجیل) و شیرین‌کنندهٔ آسپارتام

**توضیح:** توضیح PKU در سوال ۱۵ میان‌ترم آمده است. **رژیم:** شیر مخصوص بدون فنیل‌آلانین (Lofenalac/Phenyl-Free) + مقدار محاسبه‌شدهٔ فنیل‌آلانین (برای رشد) از شیر مادر یا غذا؛ میوه‌ها، سبزی‌ها و غلات کم‌پروتئین مجازند. سطح هدف فنیل‌آلانین خون ۲–۶ mg/dL. اگر رژیم رعایت شود رشد و تکامل طبیعی است؛ علائم درمان نشده: عقب‌ماندگی ذهنی، بوی کپک/موش در ادرار، پوست روشن و مو، تشنج.

۱۶ نوزاد با مشکلات متابولیک

**کدام علامت، تشخیص گالاکتوزمی را در نوزادی که با شیر تغذیه می‌شود بیشتر مطرح می‌کند؟**

**پاسخ:** زردی طولانی/زودرس همراه استفراغ، اسهال و بزرگی کبد پس از شروع شیر (و در ادامه آب مروارید و سپسیس E. coli)

**توضیح:** گالاکتوزمی: نقص آنزیم GALT و ناتوانی در تبدیل گالاکتوز (از لاکتوز شیر) به گلوکز. علائم در روزهای اول تا هفتهٔ اول بعد از شیر: **زردی، استفراغ، اسهال، هپاتومگالی، هیپوگلیسمی، تحریک‌پذیری و بی‌حالی، کاتاراکت (آب مروارید) و مستعد سپسیس با E. coli**؛ آزمایش: ادرار مثبت از نظر مواد احیاکننده (غیر از گلوکز) و GALT. درمان فوری: قطع شیر مادر/گاوی و استفاده از شیر خالی از لاکتوز (سویا یا فرمول‌های عنصری) مادام‌العمر؛ در غیر این صورت: نارسایی کبد، کاتاراکت و عقب‌ماندگی ذهنی.

۱۷ مراقبت خانواده‌محور در بستری شدن

**برای به حداقل رساندن ترس از صدمهٔ بدنی در یک نوجوان، پرستار کدام اقدام را در اولویت قرار می‌دهد؟**

**پاسخ:** حفظ حریم خصوصی و پوشش بدن، توضیح صادقانه و دادن کنترل/مشارکت در تصمیم‌ها

**توضیح:** نوجوانان (۱۲–۱۸) بیشتر از «تصویر بدنی»، ظاهر، حریم خصوصی، کنترل و جدا شدن از همسالان می‌ترسند تا خود درد. اقدامات: پوشش مناسب بدن هنگام معاینه، جداسازی از والدین هنگام نیاز، شرکت دادن او در تصمیم‌گیری، توضیح کامل و صادقانه با زبان بزرگسالان، ملاقات‌ها و ارتباط با دوستان (تلفن/فضای مجازی)، رازداری. تکرار موضوعی: سوال ۳ بلوپرینت ۴۰۴۱ (مدرسه).

۱۸ مراقبت پرستاری در نوزاد با آنومالی‌های مختلف

**اولین اقدام پرستاری در نوزاد مبتلا به فتق مادرزادی دیافراگم کدام است؟**

**پاسخ:** اینتوباسیون و تخلیهٔ معده با سوند NG/OG؛ سر بالا و خوابیدن روی سمت مبتلا؛ پرهیز از تهویه با ماسک

**توضیح:** توضیح کامل در سوال ۳ و ۱۳ میان‌ترم آمده است (اینتوباسیون، هیپوپلازی ریه، PPHN). مراقبت: لوله‌گذاری فوری، ساکشن NG/OG برای جلوگیری از اتساع روده در قفسه، پایش اکسیژن (SpO۲)، مایع کنترل‌شده، و در نهایت جراحی بعد از پایدار شدن؛ ECMO در موارد شدید. خلاصه: نباید از ماسک–آمبو استفاده شود.

۱۹ آسپیراسیون جسم خارجی

**شیرخوار ۸ ماهه‌ای پس از خوردن تکه‌ای غذا دچار انسداد کامل راه هوایی شده است. اقدام مناسب پرستار کدام است؟**

**پاسخ:** ۵ ضربهٔ پشت (بین دو کتف) + ۵ فشار قفسهٔ سینه به‌صورت متناوب تا خروج جسم؛ در صورت بی‌هوشی CPR

**توضیح:** شیرخوار (زیر ۱ سال): شیرخوار را روی ساعد با سر پایین‌تر از بدن (دمر) نگه دارید؛ ۵ ضربهٔ پشت با پاشنهٔ دست بین کتف‌ها؛ سپس به پشت برگردانید و ۵ فشار با دو انگشت روی استخوان سینه؛ تکرار تا خروج جسم یا ناهوشیاری؛ در بی‌هوشی ماساژ قلبی ۳۰:۲ شروع و قبل از هر تهویه به دهان نگاه کنید. **ضربهٔ شکمی (هایملیخ) و جارو کردن کور دهان با انگشت در شیرخوار ممنوع است** (خطر پارگی کبد/ فرو بردن جسم). برای کودک بالای یک سال، ضربات شکمی. تکرار موضوعی: سوال ۶ بلوپرینت ۴۰۴۱ (جسم خارجی).

۲۰ کودک در حال احتضار

**درک کودک سن مدرسه از مفهوم مرگ کدام است؟**

**پاسخ:** مرگ را نهایی، غیرقابل بازگشت و جهانی می‌داند؛ به علت‌ها (بیماری، تصادف) علاقه دارد و در ۷–۹ سالگی ممکن است «مرگ» را شخص‌سازی کند

**توضیح:** توضیحات کامل مفهوم مرگ در سنین مختلف در سوال ۵ بلوپرینت ۴۰۴۱ آمده است (برای خردسال). سن مدرسه: درک واقعی، ترس از درد، آسیب بدنی و ناتوانی، کنجکاوی در مورد آنچه پس از مرگ رخ می‌دهد؛ ممکن است سؤال‌های جزئی بپرسد؛ به پرسش‌ها صادقانه جواب دهید، به او اجازه دهید حرف بزند و از ابراز احساسات تحقیر نکنید. نوجوان: مفهوم کامل ولی ممکن است ابراز خشم/انکار کند.

۲۱ اختلالات آب و الکترولیت سوال تکراری

**در یک کودک ۱۸ ماهه با وزن ۱۴ کیلوگرم که به علت دهیدراتاسیون شدید نیاز به احیای مایع دارد، مناسب‌ترین مایع و حجم بولوس اولیه کدام است؟**

**پاسخ:** نرمال سالین (یا رینگر لاکتات) ۲۰ ۲۸۰ = ۱۴ × mL/kg میلی‌لیتر

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۸ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است. خلاصه: بولوس ایزوتونیک ۲۰ mL/kg در ۲۰–۳۰ دقیقه، قابل تکرار تا ۶۰ mL/kg؛ سپس مایع جایگزینی ۲۴–۴۸ ساعته.

۲۲ احیای قلبی ریوی

**هنگام احیای قلبی‌ریوی یک شیرخوار، مناسب‌ترین محل برای بررسی نبض کدام است؟**

**پاسخ:** نبض بازویی (Brachial) — سطح داخلی بازو بین آرنج و شانه

**توضیح:** در شیرخوار زیر ۱ سال گردن کوتاه و چاق است و نبض کاروتید به‌سختی لمس می‌شود، بنابراین نبض بازویی (یا فمورال) بررسی می‌شود؛ حداکثر ۱۰ ثانیه. در کودک بزرگ‌تر و بزرگسال نبض کاروتید یا فمورال. اگر نبض ندارد یا کمتر از ۶۰ ضربه در دقیقه با نشانه‌های ضعف پرفیوژن (رنگ‌پریدگی، سیانوز)، شروع ماساژ قفسهٔ سینه با ۲ انگشت (یک امدادگر) یا دو شست و دست‌های دور قفسه (دو امدادگر) با عمق ۴ سانتی‌متر (۱/۳ قطر قفسه) و سرعت ۱۰۰–۱۲۰/دقیقه؛ نسبت ۳۰:۲ (یک نفر) و ۱۵:۲ (دو نفر). تکرار موضوعی: سوال ۲ بلوپرینت ۴۰۴۱.

۲۳ مدیریت درد

**ابزار FLACC برای ارزیابی درد در کدام کودک مناسب‌تر است؟**

**پاسخ:** کودکان ۲ ماه تا ۷ سال که نمی‌توانند درد را به زبان بیان کنند؛ یا ناتوان از ارتباط کلامی/تحت بی‌هوشی/ تکامل ناکافی

**توضیح:** FLACC: Face (چهره)، Legs (پاها)، Activity (فعالیت)، Cry (گریه)، Consolability (قابلیت تسلی)؛ هر مورد ۰–۲ و مجموع ۰–۱۰. مناسب نوزاد بزرگ‌تر/شیرخوار/نوپا/پیش‌دبستانی و کودکان دارای ناتوانی ذهنی/ شناختی. سایر ابزارها: **NIPS** و **CRIES** (نوزادان)، **Wong-Baker FACES** (۳ سال به بالا، صورتک‌ها)، **مقیاس عددی NRS** (۸ سال به بالا). پرستار: کنترل درد دارویی و غیردارویی (قنداق، مکیدن، شیر مادر، آغوش، حواس‌پرتی، موسیقی، آموزش تنفس)، **استامینوفن/ایبوپروفن** برای درد خفیف و مورفین/فنتانیل برای درد شدید.

۲۴ اختلالات کلیوی سوال تکراری

**مهم‌ترین اقدام پرستار در مورد کودک مبتلا به تومور ویلمز کدام است؟**

**پاسخ:** لمس نکردن شکم + جابجایی آرام

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۰ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است. خلاصه: خطر پارگی و انتشار تومور؛ علامت «شکم را لمس نکنید»؛ پایش فشار خون و آماده‌سازی جراحی.

۲۵ اختلالات آب و الکترولیت

**کودکی مبتلا به دهیدراتاسیون هیپرتونیک در بخش بستری است. پرستار برای پیشگیری از عوارض درمان، کدام اقدام را در اولویت قرار می‌دهد؟**

**پاسخ:** اصلاح آهسته و تدریجی کمبود (۴۸ ساعت) و پایش وضعیت نورولوژیک (تشنج/ادم مغزی)

**توضیح:** دهیدراتاسیون هیپرتونیک: سدیم سرم بالای ۱۵۰ mEq/L (آب بیشتر از سدیم از دست می‌رود؛ مثلاً اسهال همراه آب کم/ORS غلیظ)؛ علائم: تشنگی شدید، بی‌قراری، پوست خمیری، تب، تشنج، زبان خشک؛ پرفیوژن نسبتاً حفظ. اگر سدیم سریع پایین بیاید (کاهش بیش از ۰٫۵ mEq/L/h)، آب با اسمز به داخل سلول‌های مغز می‌رود ← **ادم مغزی و تشنج**. پس: ابتدا بولوس ایزوتونیک برای شوک، سپس اصلاح آرام طی ۴۸ ساعت با محلول‌های ایزوتونیک/نیمه‌ایزوتونیک، سنجش سدیم هر ۲–۴ ساعت، پایش سطح هوشیاری، تشنج و برون‌ده ادرار. انواع دیگر: ایزوتونیک (۱۵۰–۱۳۰ Na، شایع‌ترین) و هیپوتونیک (<۱۳۰؛ خطر تشنج و شوک زودتر).

۲۶ اختلالات کلیوی سوال تکراری

**مادری از شما در مورد مراقبت در منزل کودک ۷ ساله مبتلا به سندرم نفروتیک سوال می‌کند، کدام پاسخ صحیح است؟**

**پاسخ:** کنترل روزانه پروتئین ادرار با نوار، پرهیز از عفونت، عدم قطع ناگهانی پردنیزولون و رژیم کم‌نمک در زمان ادم

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۲۰ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل در همان‌جا نوشته شده است.

۲۷ اختلالات کلیوی

**کدام آموزش پرستاری در کاهش خطر عود عفونت ادراری (UTI) در دختران بیشترین اهمیت را دارد؟**

**پاسخ:** رعایت بهداشت ناحیهٔ تناسلی (شست‌وشو و پاک کردن از جلو به عقب) + دفع مکرر ادرار و عدم نگه داشتن ادرار + مصرف مایعات کافی

**توضیح:** UTI در دختران به دلیل کوتاهی مجرای ادراری و نزدیکی به مقعد شایع‌تر است. علائم: تب، سوزش ادرار، تکرر، فوریت، بی‌اختیاری، درد زیرشکم، بوی بد ادرار؛ در شیرخوار: تب بدون علت، تحریک‌پذیری، بی‌اشتهایی. **آموزش:** (۱) پاک کردن از جلو به عقب؛ (۲) دفع مکرر و کامل (هر ۳–۴ ساعت) و دوبار ادرار کردن (double voiding)؛ (۳) مایعات زیاد (آب)؛ (۴) لباس زیر نخی و آزاد، دوری از دوش حباب‌دار/صابون‌های حساسیت‌زا و لباس تنگ؛ (۵) درمان یبوست؛ (۶) حمام دوش به‌جای وان؛ (۷) مصرف کامل آنتی‌بیوتیک و پیگیری کشت؛ (۸) در رفلاکس وزیکویورترال: پروفیلاکسی و پیگیری سونوگرافی/VCUG. کشت ادرار تمیز (سونداژ/نمونه میان‌جریان).

۲۸ اختلالات تنفسی سوال تکراری

**به‌عنوان پرستار، در کدام بیماری نباید برای بررسی حلق از آبسلانگ استفاده کرد، زیرا ممکن است موجب انسداد کامل راه هوایی شود؟**

**پاسخ:** اپی‌گلوتیت حاد

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۳ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است. خلاصه: ۴D (Drooling، Distress، Dysphonia، Dysphagia)، حالت سه‌پایه، عدم تحریک، آماده‌باش لوله‌گذاری در اتاق عمل.

۲۹ اختلالات تنفسی سوال تکراری

**مشاهده کدام علامت در کودک مبتلا به آسم، بیش از همه نشان‌دهندهٔ هیپوکسی شدید است و نیاز به مداخلهٔ فوری دارد؟**

**پاسخ:** سکوت ریه (قطع ویز) + سیانوز + کاهش سطح هوشیاری

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۵ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۳۰ اختلالات تنفسی

**کدام یافتهٔ بالینی، بیش از سایر موارد به نفع پنومونی باکتریایی در کودک است؟**

**پاسخ:** شروع ناگهانی با تب بالا، لرز، سرفه‌ی مولد (خلط‌دار)، درد پلورتیک و کراکل/کاهش صدای ریه موضعی؛ لکوسیتوز با نوتروفیلی و کدورت لوبار در عکس

**توضیح:** پنومونی باکتریایی (مانند استرپتوکوک پنومونیه): شروع ناگهانی، تب بالا (>۳۹)، کسالت، تاکی‌پنه، فرورفتگی قفسه سینه، سرفه با خلط، درد قفسه سینه/شکم، کراکل موضعی، ماتیته در دق و عکس «کنسولیدیشن لوبار» و WBC بالا. پنومونی ویروسی: شروع تدریجی، تب خفیف، ویز و رال‌های منتشر، سرفه خشک، عکس انفیلتراسیون بینابینی و لنفوسیتوز. «آتیپیک» (مایکوپلاسما): در کودکان مدرسه‌ای، سرفه خشک مداوم و سردرد. درمان: آموکسی‌سیلین (خط اول)، اکسیژن، مایعات، استامینوفن، فیزیوتراپی تنفسی؛ بستری: SpO۲ <۹۰٪، دیسترس تنفسی، عدم تحمل خوراکی. پیشگیری: واکسن PCV و Hib.

۳۱ اختلالات گوارشی سوال تکراری

**در مراقبت تغذیه‌ای کودک مبتلا به بیماری هیرشپرونگ قبل از جراحی، کدام رژیم غذایی مناسب‌تر است؟**

**پاسخ:** پرکالری، پرپروتئین و کم‌فیبر

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۶ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۳۲ اختلالات گوارشی سوال تکراری

**پرستار با مشاهده کدام علامت در کودک مبتلا به در هم‌فرورفتگی روده، متوجه رفع انسداد شده و باید آن را فوراً به پزشک گزارش کند؟**

**پاسخ:** دفع مدفوع طبیعی قهوه‌ای

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۲۴ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۳۳ اختلالات گوارشی سوال تکراری

**کدام یافته در معاینه شیرخوار مبتلا به تنگی هیپرتروفیک پیلور بیشتر مشاهده می‌شود؟**

**پاسخ:** توده زیتونی‌شکل قابل لمس در اپیگاستر/ربع راست فوقانی + امواج پریستالتیک قابل مشاهده روی شکم

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۲۲ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است. در معاینه بهتر است هنگام شیر خوردن یا بعد از استفراغ شکم را لمس کنند. یافتهٔ شایع‌تر از توده: امواج پریستالتیک و استفراغ پرتابی.

۳۴ اختلالات گوارشی سوال تکراری

**کودک مبتلا به سلیاک با آسیب شدید مخاط روده باریک، نیازمند حذف کدام ماده غذایی می‌باشد؟**

**پاسخ:** گلوتن (گندم، جو، چاودار)

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۹ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۳۵ اختلالات گوارشی

**برای کودک مبتلا به ریفلاکس معده به مری (GERD)، داروی مهارکنندهٔ پمپ پروتون (PPI) مانند پنتوپرازول، دو بار در روز تجویز شده است. بهترین زمان مصرف دارو کدام است؟**

**پاسخ:** ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از وعده‌های غذایی (معمولاً قبل از صبحانه و شام)، با معده خالی

**توضیح:** PPIها (امپرازول، لانسوپرازول، پنتوپرازول) پمپ پروتون سلول‌های جداری را فقط وقتی فعال است مهار می‌کنند؛ پمپ‌ها بعد از وعدهٔ غذایی/ناشتایی فعال می‌شوند، بنابراین باید ۳۰–۶۰ دقیقه قبل از غذا و با معده خالی مصرف شوند. برای دو بار در روز: قبل از صبحانه و قبل از شام. اگر کودک نمی‌تواند قرص ببلعد، در سیب‌پخته یا آب‌سیب مخلوط شود (نجویدن/له نکردن گرانول). **مراقبت GERD**: وعده‌های کم‌حجم و مکرر، غلیظ کردن شیر با برنج، خوابیدن با سر بالا و در شیرخوار به پهلو/پشت (نه شکم مگر با نظارت و برای بیداری)، پرهیز از غذاهای تحریک‌کننده و چاقی. عوارض PPI: سردرد، اسهال، و در مصرف بلندمدت خطر عفونت و کمبود Mg/B۱۲.

۳۶ اختلالات قلبی سوال تکراری

**در درمان دارویی باز ماندن کانال شریانی (PDA) در کودک، از کدام دارو برای کمک به بسته شدن کانال استفاده می‌شود؟**

**پاسخ:** ایندومتاسین (یا ایبوپروفن)

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۷ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۳۷ اختلالات قلبی سوال تکراری

**در کدام عیب مادرزادی قلب، احتمال بروز حملات ناگهانی تشدید سیانوز و هیپوکسی وجود دارد و والدین باید دربارهٔ اقدامات مناسب هنگام بروز حمله آموزش ببینند؟**

**پاسخ:** تترالوژی فالو

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۲۱ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است (وضعیت زانو–سینه، اکسیژن، مورفین، آرام کردن).

۳۸ اختلالات قلبی سوال تکراری

**در معاینهٔ نوزاد، وجود نبض قوی در اندام‌های فوقانی و نبض ضعیف در اندام‌های تحتانی، احتمال وجود کدام بیماری قلبی مادرزادی را مطرح می‌کند؟**

**پاسخ:** کوآرکتاسیون آئورت

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۱ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۳۹ اختلالات قلبی سوال تکراری

**کدام یک از موارد زیر جزء معیارهای کلاسیک بیماری کاوازاکی نمی‌باشد؟**

**پاسخ:** ملتحمهٔ چرکی/اگزوداتیو، بثورات تاولی، لنفادنوپاتی منتشر (غیر از لنف گردنی یک‌طرفه) — مهم: آنوریسم کرونر یک عارضه است

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۲۵ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است (تب ≤۵ روز + ۴ از ۵ علامت).

۴۰ اختلالات قلبی سوال تکراری

**کودکی مبتلا به نارسایی قلبی تحت درمان با دیگوکسین است. مصرف همزمان کدام دارو احتمال بروز مسمومیت با دیگوکسین را افزایش می‌دهد؟**

**پاسخ:** فوروزمید (هیپوکالمی) و همچنین آمیودارون/وراپامیل/کینیدین

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۸ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۴۱ اختلالات قلبی سوال تکراری

**در حین ساکشن شیرخوار مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی، مشاهده کدام تغییر نشان‌دهنده تحریک عصب واگ ناشی از تحریک راه هوایی است؟**

**پاسخ:** برادی‌کاردی

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۲۳ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۴۲ اختلالات خونی

**کودک مبتلا به تالاسمی پس از اسپلنکتومی ترخیص می‌شود. کدام آموزش پرستاری در پیشگیری از عوارض جدی بیماری اهمیت بیشتری دارد؟**

**پاسخ:** پیشگیری و درمان سریع عفونت: پنی‌سیلین پروفیلاکسی، واکسن‌ها (پنوموکوک، هموفیلوس، منگوکوک) و مراجعهٔ فوری با تب

**توضیح:** بعد از برداشتن طحال، بدن توانایی مقابله با باکتری‌های کپسول‌دار (پنوموکوک، هموفیلوس آنفلوآنزا، منگوکوک) را از دست می‌دهد و ممکن است سپسیس برق‌آسا (OPSI) رخ دهد. آموزش: ۱) مصرف روزانه پنی‌سیلین (یا آموکسی‌سیلین) طبق دستور؛ ۲) واکسیناسیون کامل (قبل از جراحی ≥ ۲ هفته)؛ ۳) هر تب ≥ ۳۸٫۵ یا سرمالرز = **اورژانس** و مراجعه فوری برای کشت و آنتی‌بیوتیک وریدی؛ ۴) علائم دیگر: بی‌حالی، استفراغ؛ ۵) آگاه سازی پزشکان/دندان‌پزشک؛ ۶) پرهیز از حیوانات خانگی آلوده و جلوگیری از گزش حشرات/ملاریا. موضوع هدف اسپلنکتومی در سوال ۲۶ بلوپرینت ۴۰۴۱ توضیح داده شده است.

۴۳ اختلالات خونی سوال تکراری

**کودک مبتلا به هموفیلی با خونریزی حاد داخل مفصلی مراجعه کرده است. مناسب‌ترین اقدام اولیه کدام است؟**

**پاسخ:** تزریق فوری فاکتور انعقادی (VIII/IX) همراه با RICE

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۱۴ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است.

۴۴ اختلالات خونی

**علت اصلی بروز درد استخوان در کودک مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستیک (ALL) کدام است؟**

**پاسخ:** نفوذ و تکثیر بلاست‌های لوسمیک در مغز استخوان و زیر پریوست (افزایش فشار داخل مغز استخوان)

**توضیح:** ALL شایع‌ترین سرطان کودکان (۲–۱۰ ساله): تکثیر کنترل‌نشدهٔ لنفوبلاست‌ها ← مغز استخوان پر از سلول‌های بدخیم ← جایگزینی سلول‌های سالم. **پیامدها:** کم‌خونی (رنگ‌پریدگی، خستگی)، ترومبوسیتوپنی (پتشی، خونریزی)، نوتروپنی (تب/عفونت)، **درد استخوان و مفصل** (به‌علت انبساط حفرهٔ مغز استخوان و نفوذ زیرپریوستی؛ گاه لنگش و امتناع از راه رفتن)، لنفادنوپاتی، هپاتواسپلنومگالی، درگیری CNS و بیضه. تشخیص: CBC با بلاست و آسپیراسیون مغز استخوان (>۲۵٪ بلاست). درمان: شیمی‌درمانی (القا، تحکیم، نگهدارنده) و پروفیلاکسی CNS. **پرستار:** کنترل درد، پیشگیری از عفونت (ایزولاسیون محافظتی)، مراقبت از دهان (موکوزیت)، تغذیه.

۴۵ اختلالات عصبی

**کودک ۱۸ ماهه‌ای در پی افزایش ناگهانی تب دچار تشنج شده است. مهم‌ترین اقدام پرستاری در هنگام بروز تشنج کدام است؟**

**پاسخ:** حفظ راه هوایی و ایمنی: خوابانیدن به پهلو، دور کردن اشیای خطرناک و ثبت زمان؛ عدم محدود کردن و نگذاشتن چیزی در دهان

**توضیح:** تشنج تب (۶ ماه تا ۵ سال، معمولاً <۱۵ دقیقه، تونیک–کلونیک ژنرالیزه): اقدام حین تشنج: (۱) کودک را روی زمین/تخت بخوابانید به پهلو (وضعیت ریکاوری) برای جلوگیری از آسپیراسیون؛ (۲) لباس‌های تنگ را شل کنید؛ (۳) **هرگز چیزی در دهان نگذارید یا کودک را مهار نکنید**؛ (۴) مدت تشنج و نوع حرکات را ثبت کنید؛ (۵) اکسیژن و ساکشن آماده؛ (۶) اگر <۵ دقیقه: دیازپام/میدازولام (بین بینی/رکتال) طبق دستور. بعد: کاهش تب با استامینوفن (کاهش تب خطر تشنج را کم نمی‌کند)، آرامش والدین، آموزش. تشنج بیش از ۱۵ دقیقه، کانونی یا عود در ۲۴ ساعت = «پیچیده» ← بررسی بیشتر.

۴۶ اختلالات عصبی

**کودک مبتلا به فلج مغزی تحت درمان با دانترولن سدیم قرار دارد. پرستار باید کدام عارضه را در این کودک بیشتر پایش کند؟**

**پاسخ:** مسمومیت کبدی (هپاتوتوکسیسیتی)

**توضیح:** دانترولن شل‌کنندهٔ عضلانی مستقیم است که با مهار آزادسازی کلسیم از شبکه سارکوپلاسمی اسپاستیسیته را کم می‌کند؛ مهم‌ترین عارضه جدی: **آسیب کبدی** (باید آنزیم‌های کبدی AST/ALT قبل و در طی درمان ماهانه پایش شود) و همچنین خواب‌آلودگی، ضعف عضلانی، سرگیجه و اسهال. سایر داروهای اسپاستیسیته: باکلوفن (عدم قطع ناگهانی)، دیازپام، تزریق توکسین بوتولینوم. مراقبت: فیزیوتراپی، بریس، بهبود تغذیه (موضوع سوال ۲۹ بلوپرینت ۴۰۴۱)، پیشگیری از عوارض (کنتراکچر، اسکولیوز، لوکساسیون ران).

۴۷ اختلالات غدد

**کودک مبتلا به فیبروز کیستیک برای بهبود هضم غذا از آنزیم‌های پانکراتیک استفاده می‌کند. کدام آموزش پرستاری صحیح است؟**

**پاسخ:** آنزیم را همراه با هر وعده و میان‌وعده مصرف کنید، کپسول را کامل ببلعید (نجوید و پودر نکنید)؛ برای شیرخوار مخلوط با سیب‌پخته

**توضیح:** توضیحات کامل در سوال ۳۰ بلوپرینت ۴۰۴۱ آمده است. نکات تکمیلی آموزش: (۱) ۳۰ دقیقه اول وعده/ وسط وعده؛ (۲) نباید با شیر یا غذای نشاسته‌ای که قلیایی است مخلوط شود (غیرفعال شدن آنزیم)؛ (۳) کپسول‌های روکش‌دار را باز و محتوا را روی مقدار کمی غذای اسیدی (سیب‌پخته/ماست) بپاشند؛ (۴) نیاز به دوز بیشتر در وعده‌های پرچرب؛ (۵) علائم کمبود آنزیم: مدفوع چرب/بدبو، نفخ، افزایش وزن کم؛ علائم بیش‌مصرف: درد شکم، تنگی کولون (فیبرزینگ کولونوپاتی).

۴۸ اختلالات غدد سوال تکراری

**برای درمان دهیدراتاسیون در کودک مبتلا به کتواسیدوز دیابتی (DKA) در مرحلهٔ اولیهٔ اورژانس، از کدام محلول استفاده می‌شود؟**

**پاسخ:** نرمال سالین ۰٫۹٪

**توضیح: این سوال تکراری است** با سوال ۳۱ بلوپرینت ۴۰۴۱؛ توضیح کامل آنجا نوشته شده است (بولوس ۱۰–۲۰ mL/kg، انسولین رگولار پس از ۱ ساعت، افزودن پتاسیم، ریسک ادم مغزی).